Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprapto Kav. 20, No. 14, Cempaka Putih,
PO. Box 1391 / JKT, Jakarta 10510 Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (hunting), 424 6063,
Fax. +62 21 421 2940

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id



Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG

Edisi 2

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG

Edisi 2

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
PANDUAN PENATALAKSANAAN SOLUSI PERMASALAHAN KLAIM INA CBG
TAHUN 2018

No : JP.02.03/3/2411/2018
No : 620 / BA / 1118

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Kalsum Komaryani, MPPM
   Jabatan : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
2. Nama : dr. Budi Mohamad Arief, MM, AAK
   Jabatan : Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan

Berdasarkan dari hasil pertemuan kedua belah pihak pada pembahasan Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Tahun 2018, telah disepakati diagnosis dan tindakan prioritas yang terdiri atas aspek koding, medis dan administrasi.

Hasil kesepakatan dalam lampiran berita acara ini menjadi referensi bersama bagi BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit dalam melaksanakan proses verifikasi klaim INA CBG.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh para pihak secara sukarela tanpa ada paksaan apapun.

Kepala PPJK
Kementerian Kesehatan RI

dr. Kalsum Komaryani, MPPM

Deputi Direksi Bidang JPK Rujukan
BPJS Kesehatan

dr. Budi Mohamad Arief, MM, AAK

Daftar Isi

Berita Acara .....

Kata Pengantar ii

Bab I Manual koding 1

I. Penyakit-Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu 1

II. Neoplasma 22

III. Penyakit Darah, Organ Pembuat Darah, dan Kelainan Tertentu Yang Melibatkan Mekanisme Imun .. 26

IV. Penyakit-Penyakit Endokrin, Nutrisi dan Metabolik 29

V. Kelainan Jiwa dan Tingkah Laku 37

VI. Penyakit-Penyakit Sistem Sirkulasi 38

VII. Penyakit-Penyakit Sistem Pernafasan 50

VIII. Penyakit-Penyakit Sistem Pencernaan 61

IX. Penyakit Kulit dan Jaringan Subkutis 66

X. Penyakit-Penyakit Sistem Genitourinarius 68

XI. Kehamilan, Melahirkan, dan Nifas 78

XII. Kondisi Tertentu Yang Dimulai Pada Periode Perinatal 85

XIII. Malformasi, Deformasi Dan Kelainan Kromosom Kongenital 86

XIV. Gejala, Tanda, dan Hasil Abnormal Klinis Dan Laboratorium, Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain ... 87

XV. Cedera, Keracunan, dan Akibat Lain Tertentu Penyebab Eksternal 94

XVI. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Kontak Dengan Pelayanan Kesehatan .. 97

Tindakan / Prosedur 99

I. Operasi pada Sistem Saraf 99

II. Operasi pada Mata 101

III. Operasi pada Telinga 103

IV. Operasi pada Sistem Pernapasan 104

V. Operasi pada Sistem Kardiovaskular 105
VI. Operasi pada Sistem Pecernaan 107
VII. Operasi pada Sistem Saluran Kencing 112
VIII. Operasi pada Organ Kelamin Laki-Laki 114
IX. Operasi pada Organ Kelamin Perempuan 115
X. Prosedur/Tindakan Obstetrik 117
XI. Operasi pada Sistem Muskuloskeletal 120
XII. Operasi pada Sistem Integumentary 124
XIII. Prosedur/Tindakan Diagnostik dan Terapeutik Lainnya 127
Bab II Administrasi 139
Bab III Kasus Medis 151

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), BPJS Kesehatan sebagai Badan Penyelenggara merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia, diamanatkan untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu dan kendali biaya, serta sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif guna tercapainya sustainibilitas program JKN.

Beberapa upaya kendali mutu dan kendali biaya telah dilakukan sejak beroperasionalnya BPJS Kesehatan. Salah satu kendali biaya yang telah dilakukan adalah melalui upaya penyelesaian klaim-klaim bermasalah yang diinventarisir baik dari BPJS Kesehatan maupun dari Kementerian Kesehatan. Bentuk kesepakatan upaya penyelesaian klaim bermasalah antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Organisasi Profesi dituangkan pertama kali dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK 03.03/X/1185/2015 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dalam Penyelenggaraan JKN yang memuat tentang 17 (tujuh belas) kasus permasalahan koding dan 18 (delapan belas) kasus permasalahan klinis. Tidak berhenti sampai di situ, penyempurnaan terhadap upaya penyelesaian permasalahan klaim terus dilakukan hingga diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/63/2016 dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/518/2016 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Klaim INA-CBG dalam Penyelenggaraan JKN yang mana dalam Surat Edaran terakhir telah disepakati penyelesaian terhadap 20 (dua puluh) kasus permasalahan koding, 49 (empat puluh sembilan) kasus permasalahan klinis, serta 2 (dua) kasus permasalahan klinis dan mekanisme pengajuan klaim.

Pada tahun 2018 ini, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan kembali menyusun penyelesaian terhadap permasalahan klaim yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama mengenai Panduan Penatalaksanaan Solusi Permasalahan Klaim INA CBG Tahun 2018. Dalam Berita Acara tersebut terdiri dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) kasus dengan rincian 208 (dua ratus delapan) kasus permasalahan koding, 63 (enam puluh tiga) kasus permasalahan medis/klinis, dan 10 (sepuluh) kasus permasalahan administrasi pengajuan klaim.

Panduan Manual Verifikasi Klaim INA CBG Edisi 2 ini, disusun berdasarkan diagnosa dan prosedur terbanyak yang terdiri atas manual verifikasi terkait koding, aspek klinis, dan administrasi. Diharapkan dengan adanya Manual Verifikasi Klaim INA CBG Edisi 2 ini dapat meminimalisir terjadinya dispute claim baik dari sisi koding, klinis, maupun administrasi.

Jakarta, Desember 2018

Kedeputian Bidang JPKR
BPJS Kesehatan



Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG

Edisi 2

KODING

DIAGNOSIS

I. Penyakit-Penyakit Infeksi dan Parasit Tertentu

1

Diagnosa	:	Typhoid Fever (A01)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Typhoid fever Infection due to Salmonella typhi A01.0 Paratyphoid fever A A01.1 Paratyphoid fever B A01.2 Paratyphoid fever C A01.3 Paratyphoid fever, unspecified A01.4 - Infection due to Salmonella paratyphi NOS
Perhatian Khusus	:	Penegakan diagnosis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK. 02.02/ MENKES/514/2015. Perhatikan Dagger dan Asterisk.

2

Diagnosa	:	Typhoid pada kehamilan (dirawat oleh dokter spesialis dalam)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Jika tidak ada diagnosis lainnya, maka pengkodean untuk kasus tifoid pada kehamilan menggunakan kode O98.8 sebagai diagnosis utama dan kode A01.0 sebagai diagnosis sekunder
Perhatian Khusus	:	Sesuai PMK No.76 Tahun 2016. Jika dalam ICD-10 terdapat catatan seperti Use

additional code, if desired, to identify specified condition, maka kode tersebut dapat digunakan sesuai dengan kondisi pasien.

3

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk Typhoid fever (A01) dengan Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin menjadi Salmonella enteritis

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin fever (A09) yang menyatakan gastroenteritis and colitis due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents mengarah pada kode spesifik sesuai dengan organismenya (A00-A08). Sehingga kode A09 seharusnya tidak dikoding lagi apabila sudah ada typhoid fever (A01.0) yang tegak secara medis. Tidak ada instruksi khusus untuk menggabungkan antara A01.0 dengan A09 menjadi salmonella, enteritis (A02.0) baik dari volume I maupun III.

Perhatian Khusus : -

4

Diagnosa : Diare (A09)

Prosedur : -

Aspek Koding : Diare noninfeksius menggunakan kode : K52.9
Diare noninfeksius pada neonatus menggunakan kode: P78.3.

Mohon diperhatikan pada ICD-10 Revisi Tahun 2010 terkait koding A09.- A09.0 dan A09.9 digunakan untuk diare yang penyebabnya tidak diketahui penyebabnya. Jika penyebab diare sudah diketahui maka gunakan kode spesifik. Jika disebabkan oleh bakteri, protozoa, virus, dan organisme spesifik lainnya : A00-A08.

ICD 10 2010 Volume 1

A09 Other gastroenteritis and colitis of infectious and unspecified origin
Excludes: due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents (A00-A08)
Noninfective (see noninfectious) diarrhoea (K52.9)
· neonatal (P78.3)

Perhatian Khusus : Diare yang merupakan gejala/bagian dari suatu infeksi (contoh: Thypoid) tidak perlu dikoding terpisah dari penyakit utamanya sebagai sumber infeksi atau tidak dijadikan DU.

Contoh : GE akibat infeksi Entamoeba Histolytica disebut disentri dikoding dengan menggunakan kode A06.0

Sesuai ICD 10 2010 Volume 1, diagnosa diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09) dengan Typhoid fever (A01.0) dikode kombinasi dengan Typhoid fever (A01.0)

5

Diagnosa	:	TB dengan Pneumonia/Bronkhopneumonia menggunakan kode gabung yaitu A15/A16
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Secara kaidah ICD 10 terdapat kode A16.2 Tuberculosis of lung dengan penjelasan bahwa kondisi Tuberculous pneumonia sudah termasuk (include) dalam kode A16.2.
Perhatian Khusus	:	-

6

Diagnosa	:	Tuberculosis of lung, confirmed by culture only (A15.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	A15.1 Tuberculosis of lung, confirmed by culture only Hanya digunakan pada TB paru yang sudah ditegakan melalui kultur. Perhatikan pada sub bab (A15-A19) termasuk kondisi : infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan Myocobacterium bovis Perhatikan pada kondisi TB paru yang lainya digunakan kode tersendiri: congenital tuberculosis : P37.0 human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis : B20.0 pneumoconiosis associated with tuberculosis : J65

sequelae of tuberculosis : B90
silicotuberculosis : J65

Perhatian Khusus : -

7

Diagnosa : Tuberculosis of lung, confirmed histologically (A15.2)

Prosedur : -

Aspek Koding : A15.2 Tuberculosis of lung, confirmed histologically

Hanya digunakan pada TB paru yang sudah ditegakan melalui pemeriksaan histologis.

Perhatikan pada sub bab (A15-A19)
termasuk kondisi : infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan Myocobacterium bovis

Perhatikan pada kondisi TB paru yang laiinya digunakan kode tersendiri:

congenital tuberculosis : P37.0
human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis : B20.0
pneumoconiosis associated with tuberculosis : J65
sequelae of tuberculosis : B90
silicotuberculosis : J65

Perhatian Khusus : -

8

Diagnosa	:	Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means (A15.3)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	A15.3 Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means Digunakan pada kondisi TB paru yang sudah tegak namun tidak dapat dipastikan secara bakteriologi ataupun histologis. Perhatikan pada kondisi TB paru yang lainya digunakan kode tersendiri: congenital tuberculosis : P37.0 human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis : B20.0 pneumoconiosis associated with tuberculosis : J65 sequelae of tuberculosis : B90 silicotuberculosis : J65
Perhatian Khusus	:	-

9

Diagnosa	:	Tuberculous pleurisy, conf bacteriologically/his'y (A15.6)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	A15.6 Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically Tuberculosis of pleura

Tuberculosis empyema --> comfirmed bacteriologically and histologically

Excludes : in primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically (A15.7)

Perhatian Khusus : Perhatikan pada sub bab (A15-A19)
Includes : infections due to Mycobacterium tuberculosis and Myocobacterium bovis

Excludes : congenital tuberculosis (P37.0)
human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis (B20.0)
pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65)
sequelae of tuberculosis (B90,-)
silicotuberculosis (J65)

10

Diagnosa : Tb lung without mention of bacteriological or histological confirmation (A16)

Prosedur : -

Aspek Koding : Kriteria inklusi sub bab:
Infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis

Kriteria eksklusi sub bab:
congenital tuberculosis (P37.0)
human immunodeficieny [HIV] disease resulting in tuberculosis (B20.0)
pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65)

sequelae of tuberculosis (B90.-)
silicotuberculosis (J65)

Kriteria inklusi : bronkiektasis, fibrosis paru, pneumonia, pneumothorax (tidak perlu dikoding terpisah)

Perhatian Khusus : Hanya digunakan untuk infeksi tuberkulosa pada paru.

Untuk organ lain digunakan koding tersendiri, contoh: meningitis tuberkulosis (A17) , Tb tulang dan sendi (A18), kondisi multipel (A19). Catatan kondisi multiple (A19) pada ICD 10 Vol. I lebih mengarah pada kondisi TB Miliary
Perhatikan kesesuaian kode TB dengan organ dan dengan pemeriksaan penunjang (bakteriologis dan histologis). Jika hasil pemeriksaan penunjang positif Tb maka gunakan kode A15.-

Cermati ICD 10 volume 1 dan 3 untuk kaidah dan dagger asterisk.

11

Diagnosa : Tuberculosis of lung, bacteriologically & histolog'y neg (A16.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : A16.0 Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative

Digunakan pada kondisi TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologi dan histologi negatif.

Termasuk didalamnya kondisi tuberculous :
- bronchiectasis
- fibrosis of lung
- pneumonia
- pneumothorax

} bacteriologically and histologically negative

Perhatikan pada sub bab (A15-A19)
Includes : infections due to Mycobacterium tuberculosis and Myocobacterium bovis

Excludes : congenital tuberculosis (P37.0)
human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis (B20.0)
pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65)
sequelae of tuberculosis (B90,-)
silicotuberculosis (J65)

Perhatian Khusus : -

12

Diagnosa : Tuberculosis lung bact and histological examin not done (A16.1)

Prosedur : -

Aspek Koding : A16.1 Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done
Conditions listed in A16.0, bacteriological and histological examination not done

Perhatikan pada sub bab (A15-A19)
Includes : infections due to Mycobacterium tuberculosis and Myocobacterium bovis

Excludes : congenital tuberculosis (P37.0)

human immunodeficiency HIV disease resulting in tuberculosis (B20.0)
pneumoconiosis associated with tuberculosis (J65)
sequelae of tuberculosis (B90,-)
silicotuberculosis (J65)

Perhatian Khusus : -

13

Diagnosa : TB dengan Malnutrisi

Prosedur : -

Aspek Koding : Kode kombinasi TB (A16.9) dengan malnutrisi hanya untuk kasus marasmus yaitu kode E41.

Perhatian Khusus : Kriteria malnutrisi sesuai dengan PNPK PDGKI.

14

Diagnosa : Diagnosa utama TB dengan diagnosa sekunder Pneumonia/Bronkhopneumonia dan septicaemia

Prosedur : -

Aspek Koding : Kode Pneumonia (J18.9) dengan TB Paru (A15.2 atau A16.2) sudah termasuk dalam kode A15.2 atau A16.2 (pastikan hasil pemeriksaan penunjang).

Kode A16.2 digunakan untuk TB Paru tanpa pemeriksaan bacteriologi atau histologi.
Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan septicaemia, unspecified (A41.9) baik dari volume I maupun III. Kode septicaemia

due to streptococcus pneumoniae (A40.3) dapat digunakan apabila sepsis yang sudah jelas disebabkan oleh organisme spesifik yaitu streptococcus pneumoniae yang tegak secara medis.

Perhatian Khusus : -

15

Diagnosa : Sepsis dengan shock sepsis (A41.9 + R57.2)

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai dengan ICD 10 Vol. I Tahun 2010 bahwa untuk kode Sepsis, unspesified (A41.9) termasuk septic shock dan septicaemia dan terdapat catatan Use additional code (R57.2), if desired, to identify spesified condition.
Perhatikan Exclude :
bacteraemia NOS (A49.9)
during labour (O75.3)
following:
- abortion or ectopic or molar pregnancy (O03-O07, O08.0)
- immunization (T88.0)
- infusion, transfusion or therapeutic injection (T80.2)

sepsis (due to)(in):
- actinomycotic (A42.7)
- anthrax (A22.7)
- candidal (B37.7)
- Erysipelothrix (A26.7)
- extraintestinal yersiniosis (A28.2)

- gonococcal (A54.8)
- herpesviral (B00.7)
- listerial (A32.7)
- meningococcal (A39.2-A39.4)
- neonatal (P36.-)
- postprocedural (T81.4)
- puerperal (O85)
- streptococcal (A40.-)
- tularaemia (A21.7)

septic:
- melioidosis (A24.1)
- plague (A20.7)
- toxic shock syndrome (A48.3)

Perhatian Khusus : Perhatikan tatalaksana

16

Diagnosa : Shock sepsis

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai dengan ICD 10 Tahun 2010, Shock sepsis menggunakan kode R57.2

Perhatian Khusus : Pasien datang dengan kondisi klinis shock sepsis. Perhatikan tatalaksana untuk kondisi shock sepsis.

17

Diagnosa : Kode kombinasi A41.9 dengan J18.9 menjadi A40.3

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified

(J18.9) dengan septicaemia, unspecified (A41.9) baik dari volume I maupun III. Secara kaidah, kedua kode digunakan bersamaan.

Perhatian Khusus : Kode septicaemia due to streptococcus pneumoniae (A40.3) digunakan apabila sudah tegak ditemukan kuman streptococcus pneumoniae pada penunjang medis.

18

Diagnosa : Pada kasus dengan Septicaemia, unspecified (A41.9) dan Cardiogenic shock cukup dikode dengan Septicaemia, unspecified

Prosedur : -

Aspek Koding : Kaidah ini hanya berlaku pada mortality code, sedangkan yang digunakan dalam pengajuan klaim adalah morbidity code. Pada kaidah morbidity tidak ada instruksi includes / excludes dari kode septicaemia, unspecified (A41.9) dengan kode cardiogenic shock (R57.0) baik dari volume I maupun III sehingga cardiogenic shock dapat dikoding.

Perhatian Khusus : Pengajuan klaim menggunakan kaidah morbidity code.

19

Diagnosa : Gas Gangrene (A48.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai kaidah ICD-10 Tahun 2010 jika gangrene saja dapat dikode R02, Gas Gangrene dikode

A48.0 dan gangrene pada DM diberi kode E10-E14 (sesuai dengan jenis DM) dengan digit terakhir .5 (contoh Gangrene DM Tipe 2 di kode E11.5).

R02 Gangrene, not elsewhere classified

Perhatikan pada sub bab ICD 10 Volume 1 :
R02 Ganrene, NEC
kecuali pada kondisi :
- atherosclerosis (I70.2)
- diabetes mellitus (E10-E14 with common fourth character. 5)
- other peripheral vascular disease (I73,-)
gangrene of certain specified sites
- see Alphabetical Index
gas gangrene (A48.0)
pyoderma gangrenosum (L88)

Perhatian Khusus : -

20

Diagnosa : "Kombinasi Diagnosis A419 Septicaemia, unspecified, Diagnosis R571 Hypovolaemic shock Kode revisi A419 Septicaemia, unspecified

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada kriteria excludes dan includes pada ICD 10 volume I dan III, sehingga A41.9 dan R 57.1 tidak bisa digabungkan

Perhatian Khusus : Kode A41.9 dan R57.1 dapat dikoding bersamaan

21

Diagnosa	:	Bacterial infection, unspecified (A49.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	A49.9 Bacterial infection, unspesified Bacteraemia NOS Pada kategori A49 eksklusi : bacterial agent as the cause of disease classified to other chapters (B95 - B96) chlamydial infection NOS (A74.9) meningococcal infektion NOS (A39.9) rickettsial infection NOS (A79.9) spirochaetal infection NOS (A69.9)
Perhatian Khusus	:	Kode ini digunakan jika tidak dapat ditentukan fokus infeksi sampai akhir episode rawat.

22

Diagnosa	:	Dengue Fever (A90)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Exclude : Dengue haemorrhagic fever (A91)
Perhatian Khusus	:	-

23

Diagnosa	:	Dengue Haemorrhagic Fever (A91)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Dengue Haemorrhagic Fever menggunakan kode A91

Perhatian Khusus	:	Untuk kasus Dengue Shock Syndrome (DSS) menggunakan kode A91 sebagai diagnosis utama, penambahan diagnosis sekunder syok disesuaikan dengan penegakan diagnosis dan tata laksana yang diberikan.

24

Diagnosa	:	Measles without complication (B05.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	B05.9 Measles without complication Measles NOS Perhatikan pada kategori Includes : morbilli Excludes : subacute selerosing panencephalitis (A81.1)
Perhatian Khusus	:	Kondisi measles dapat disertai dengan komplikasi. Perhatikan kode asterisk dagger untuk komplikasi tersebut. Perhatikan kode asterisk dan dagger sesuai Volume I ICD-10 Revisi Tahun 2010 ex : Measles with Pneumonia B05.2+ J17.1*

25

Diagnosa	:	Diagnosa utama HIV dengan diagnosa sekunder TB
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Menggunakan kode kombinasi B20.0 (HIV disease resulting in mycobacterial infection) sebagai diagnosa utama. TB tidak dikoding sebagai diagnosa sekunder.

Perhatian Khusus : -

26

Diagnosa : Kombinasi Diagnosis B20.0 HIV disease resulting in mycobacterial infection Diagnosis J15.9 Bacterial pneumonia, unspecified
Kode revisi B207 HIV disease resulting in multiple infections

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai Permenkes 76, sebagai diagnosis utama B20.7 dan kondisi lainnya dikoding sebagai diagnosis sekunder.

Perhatian Khusus : -

27

Diagnosa : Kombinasi Diagnosis B20.1 HIV disease resulting in other bacterial infections Diagnosis J15.2 Pneumonia due to staphylococcus
Kode revisi B20.7 HIV disease resulting in multiple infections

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai Permenkes 76 Tahun 2016,sebagai diagnosa utama B20.7 dan kondisi lainnya dikoding sebagai diagnosa sekunder. Namun perlu dikonfirmasi yang dimaksud infeksi bakteri pada B20.1 bukan bakteri staphylococcus.

Perhatian Khusus : -

28

Diagnosa	:	Koding kasus multiple infection pada pasien HIV menggunakan kode B20.7 (HIV disease resulting in multiple infections) sebagai diagnosis primer dan kode diagnosis B23.8 (HIV disease resulting in other specified conditions) sebagai diagnosis sekunder
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	B23.8 digunakan untuk HIV disease resulting in other specified conditions yaitu kondisi spesifik lain yang terjadi akibat penyakit HIV.
Perhatian Khusus	:	Pastikan tercatat dalam resume medis ada hubungan sebab akibat antara HIV dengan penyakit lainnya tersebut.

29

Diagnosa	:	Viral Infection, unspecified (B34.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kriteria eksklusi: cytomegaloviral disease NOS (B25.9) herpesvirus [herpes simplex] infection NOS (B00.9) retrovirus infection NOS (B33.3) Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters (B97.-)
Perhatian Khusus	:	Perhatikan untuk infeksi viral yang etiologinya diketahui dan sistem organ spesifik

30

Diagnosa : Tinea corporis (B35.4)

Prosedur : -

Aspek Koding : B35.4 Tinea corporis
Ringworn (kurap) badan

Perhatikan include pada kategori : favus
infeksi karena spesies dari Epidemophyton Microsporum dan Trichophyton tinea, beberapa tipe kecuali yang ada di B36,-

Perhatikan ekslude pada sub bab :
untuk hypertensitivity disebabkan oleh debu organik (J67,-)
mycosis fungoides (C84.0)

Perhatian Khusus : -

31

Diagnosa : Candidal stomatitis (B37.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : B37.0 Candidal stomatitis
termasuk : oral thrush (Kandidiasis pada rongga mulut)

Perhatian Khusus : Termasuk kondisi Kandidosis, moniliasis.
Kode tersendiri untuk kondisi : kandidiasis neonatus P37.5

32

Diagnosa	:	Candidiasis, unspecified (B37.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	B37.9 Kandidiasis, tidak dijelaskan Lokasi kandidiasis tidak dijelaskan.
Perhatian Khusus	:	Termasuk kondisi Kandidosis, moniliasis. Kode tersendiri untuk kondisi : kandidiasis neonatus P37.5 Pastikan dan lakukan konfirmasi mengenai lokasi lesi dan penyebab infeksi. Jika sudah spesifik, maka gunakan kode yang sesuai.

33

Diagnosa	:	Other severe and complicated plasmodium falciparum malaria (B50.8)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	B50.8 Malaria plasmodium berat dan komplikasi lainnya termasuk : infeksi plasmodium falsiparum yang bercampur dengan plasmodium lainnya Perhatikan eksklusi pada sub bab : Amoebiasis (A06,-) penyakit prozoa usus lainnya (A07,-)
Perhatian Khusus	:	-

34

Diagnosa	:	Ancylostomiasis (B76.0)
Prosedur	:	-

Aspek Koding	:	B76.0 Ancylostomiasis Infeksi Ancylostoma sp
Perhatian Khusus	:	Termasuk didalamnya : Uncinariasis

35

Diagnosa	:	Ascariasis, unspecified (B77.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	B77.9 Askariasis, tidak dijelaskan B77 Askariasis Termasuk : Askaridiasis
Perhatian Khusus	:	Infeksi cacing gelang Perhatikan kode dagger asterisk dengan pneumonia dan komplikasi intestinal.

II. Neoplasma

36

Diagnosa	:	Soft Tissue Tumor
Prosedur	:	Eksisi (83.39)
Aspek Koding	:	Indikasi tindakan soft tissue tumor yang dilakukan dengan narkose umum dengan salah satu kriteria dibawah ini : 1. Deep soft tissue tumor 2. Meluas ke struktur vital 3. Ukuran dimensi salah satu > 4 cm 4. Keganasan 5. Perlu rekonstruksi 6. Lokasi: head & neck soft tissue tumor yang dilakukan dengan narkose lokal yaitu dengan salah satu kriteria : 1. Superficial soft tissue tumor 2. Lokal, tidak meluas ke struktur vital 3. Ukuran dimensi salah satu < 4 cm 4. Tidak perlu rekonstruksi Kriteria STT yang memerlukan rawat inap : 1. Perlu tindakan dengan narkose umum 2. Meluas ke struktur vital (pembuluh darah, saraf atau organ vital) 3. Keganasan Kriteria soft tissue tumor sesuai lokasi yaitu : - Superficial : tumor terletak di atas dari fascia tanpa ada infiltrasi

- Deep : tumor di bawah fascia /tumor menginfiltrasi dan disertai dengan pemeriksaan imaging bila tersedia di fasilitas kesehatan.

Perhatian Khusus : Perhatikan keterangan Excludes dalam ICD 9CM :
bursectomy (83.5)
excision of lesion of skin and subcutaneous tissue (86.3)
synovectomy (80.70-80.79)

37

Diagnosa : Benign neoplasm (D10 - D36)

Prosedur : -

Aspek Koding : Terdapat 5 jenis kode untuk neoplasma. Malignan primer, malignan sekunder, in situ, benigna, dan uncertain or unknown behaviour (tidak diketahui). Untuk kode diagnosis dapat merujuk ke indeks alfabet Volume III ICD-10 Revisi Tahun 2010

Perhatian Khusus : Pastikan hasil pemeriksaan penunjang sesuai antara jenis tumor/neoplasma dengan kode yang digunakan.

38

Diagnosa : Diagnosa kombinasi untuk D14.3 dan J90 adalah C78.2

Prosedur : -

Aspek Koding : C78.2 bukan kode gabungan antara kode benign neoplasm of bronchus lung (D14.3) dan pleural effusion, not elsewhere classified (J90). C78.2 dikoding jika efusi pleura menunjukkan

keganasan yang tegak secara medis. Perhatikan juga diagnosis utama atau sekunder lain apakah sudah pernah ditegakkan primary cancer. Jika tidak ada riwayat primary cancer, namun ditemukan keganasan pada cairan pleura maka dikoding C38 (konfirmasi DPJP).

Perhatian Khusus : Hanya jika hasil pemeriksaan cairan pleura terbukti keganasan. Jika tidak terbukti keganasan maka tetap dikode sebagai J90

39

Diagnosa : Tumor mammae sinistra (D24)

Prosedur : Eksterpasi tumor mammae

Aspek Koding : Jika prosedur yang dilakukan pada payudara (kulit atau subkutan) maka menggunakan kode 85.-
Jika prosedur tersebut adalah biopsi dengan jarum maka menggunakan kode 85.11
Jika prosedur tersebut adalah biopsi dengan open biopsi maka menggunakan kode 85.12
Jika prosedur tersebut adalah eksisi tumor atau bagian lain pada payudara maka menggunakan kode 85.2- (disesuaikan lokasi eksisi)

Perhatian Khusus : Pastikan prosedur yang dilakukan.

40

Diagnosa : Tumor rongga pelvis (D36.7+)
Anemia (D63.0*)
Hypoalbumin (E88.0)
ISK (N39.0)

Prosedur	:	Laparatomi eksisi
Aspek Koding	:	Jika prosedur eksisi pada rongga pelvis daerah peritonium maka dikode 54.4 Jika prosedur untuk biopsi maka dikode 54.23 Jika prosedur untuk eksisi pada rongga perlvis daerah peritoneum dan biopsi maka menggunakan kode 54.4 (eksisi) dan 54.23 (biopsi)
Perhatian Khusus	:	Perhatikan hasil pemeriksaan penunjang struktur jaringan.

41

Diagnosa	:	Penggunaan Kode C78.2 Secondary malignant neoplasm of pleura sebagai Diagnosa Sekunder untuk Efusi Pleura (J90) untuk kasus keganasan bronchus dan paru
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	ICD 10 2010 Effusion - pleura, pleurisy, pleuritic, pleuropericardial J90 - - chylous, chyliform J94.0 - - fetus or newborn P28.8 - - influenzal (see also Influenza, with, respiratory manifestations) J11.1 - - malignant NEC C78.2
Perhatian Khusus	:	Kode C78.2 hanya jika hasil pemeriksaan cairan pleura terbukti keganasan. Jika tidak terbukti keganasan maka tetap dikode sebagai J90

III. Penyakit Darah, Organ Pembuat Darah, dan Kelainan Tertentu Yang Melibatkan Mekanisme Imun

42

Diagnosa	:	Tumor pedis (D16.3)
Prosedur	:	Eksterpasi besar tumor pedis
Aspek Koding	:	Untuk kode 77.68 (Local excision of lesion or tissue of bone) merupakan kode untuk prosedur pengangkatan lesi/tumor yang berasal dari jaringan tulang tarsal dan metatarsal. Kode 77.48 (Biopsy of bone) merupakan kode untuk prosedur eksisi dengan tujuan biopsi dari tulang tarsal dan metatarsal.
Perhatian Khusus	:	Pastikan di laporan operasi apakah dilakukan Eksisi atau Biopsi.

43

Diagnosa	:	Beta Thallasemia (D56)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Thalasemia Mayor menggunakan kode D56.1 D56.0 Alpha thalassaemia Excl.: hydrops fetalis due to haemolytic disease (P56.) D56.1 Beta thalassaemia, Cooley anaemia, Severe beta thalassaemia, Thalassaemia: intermedia, major

D56.2 Delta-beta thalassaemia

D56.3 Thalassaemia trait

D56.4 Hereditary persistence of fetal haemoglobin [HPFH]

D56.8 Other thalassaemias

D56.9 Thalassaemia, unspecified
Mediterranean anaemia (with other haemoglobinopathy)

Thalassaemia (minor)(mixed)(with other haemoglobinopathy)

Perhatian Khusus : Jika pasien Thalasemia Mayor pada saat kontrol ulang diberikan obat kelasi besi (Deferipone, Deferoksamin, dan Deferasirox) maka diinputkan sebagai rawat jalan dengan menggunakan kode D56.1 sebagai diagnosis utama

Sebagai kelengkapan berkas top up INA-CBG harus dilampirkan product batch obat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2016 bahwa pengajuan klaim pada pelayanan thalasemia mayor baik rawat jalan atau rawat inap yang menerima terapi kelasi besi dilakukan 1 kali dalam 1 bulan.

Kriteria rawat inap ditentukan oleh DPJP sesuai dengan indikasi medis dan Panduan Praktik Klinis masing-masing Rumah Sakit

44

Diagnosa	:	Anemia (D64.9)
Prosedur	:	Transfusi, terapi ertiropoetin (pada kasus gagal ginjal)
Aspek Koding	:	Kriteria ekslusi : refractory anaemia: NOS (D46.4) with excess of blasts (D46.2) with excess of blasts -- with transformation (C92.0) with sideroblasts (D46.1) without sideroblasts (D46.0)
Perhatian Khusus	:	Terdapat kode anemia khusus yang sesuai dengan penyebab dan kondisi yang menyertai contoh: anemia pada penyakit kronis D63.8, anemia pada keganasan D63.0, anemia pada perdarahan akut D62.

45

Diagnosa	:	Coagulation Defects, purpura and other Haemorrhage conditions
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Disseminated intravascular coagulation (DIC) menggunakan kode D65. Jika Coagulation defect, unspecified menggunakan kode D68.9
Perhatian Khusus	:	Pastikan diagnosis dan tata laksana sesuai dengan yang tercatat pada resume medis.

IV. Penyakit-Penyakit Endokrin, Nutrisi dan Metabolik

46

Diagnosa : Thyrotoxicosis, unspecified (E05.9)

Prosedur : -

Aspek Koding : E05.9 Tirotoksikosis, tidak jelas
Termasuk didalamnya:
Hipertiroidisme NOS
Penyakit jantung tiroid† (I43.8*)

E05 Thyrotoxicosis (Hyperthyroidism)
Kecuali : Tiroiditis kronis dengan tirotoksikosis sementara E06.2
Tirotoksikosis neonatus P72.1

Perhatian Khusus : -

47

Diagnosa : Diabetes mellitus (E10-14)

Prosedur : -

Aspek Koding : .0 With coma
Diabetic:
coma with or without ketoacidosis
hyperosmolar coma
hypoglycaemic coma
Hyperglycaemic coma NOS

.1 With ketoacidosis
Diabetic:
acidosis
ketoacidosis

without mention of coma

.2+ With renal complications
Berlaku dagger asterisk yaitu E11.2† dan N08.3*
pada kondisi:
Diabetic nephropathy (N08.3*)
Intracapillary glomerulonephrosis (N08.3*)
Kimmelstiel-Wilson syndrome (N08.3*)

.3+ With ophthalmic complications Diabetic:
cataract (H28.0*)
retinopathy (H36.0*)

.4+ With neurological complications Diabetic:
amyotrophy (G73.0*)
autonomic neuropathy (G99.0*)
mononeuropathy (G59.0*)
polyneuropathy (G63.2*)
autonomic (G99.0*)

.5 With peripheral circulatory complications
Diabetic:
gangrene
peripheral angiopathy+ (I79.2*)
ulcer

.6 With other specified complications
Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
.7 With multiple complications
.8 With unspecified complications
.9 Without complications
Kriteria eksklusi:
diabetes mellitus (in):
malnutrition-related (E12.-)

neonatal (P70.2)
pregnancy, childbirth and the puerperium (O24.-)
glycosuria:
NOS (R81)
renal (E74.8)
impaired glucose tolerance (R73.0)
postsurgical hypoinsulinaemia (E89.1)"

Perhatian Khusus : Hypoglycemia pada diabetic coma menggunakan kode E10-E14 dengan karakter keempat .0 (tidak dikoding terpisah).

Pastikan terdapat tatalaksana khusus untuk kondisi komplikasi.

48

Diagnosa : Kode kombinasi untuk diabetes melitus yang disertai dengan gangguan pembuluh darah tepi, ulkus pada kulit, atau gangren (E10-E14.5)

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai kaidah ICD 10 pada sub bab Diabetes (E10-E14) menggunakan kode kombinasi diabetes with peripheral circulatory complications (.5). Gangguan pembuluh darah tepi, ulkus pada kulit, atau gangren tidak dikode sebagai diagnosa sekunder.

Perhatian Khusus : -

49

Diagnosa	:	DM dengan malnutrisi
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Sesuai dengan instruksi includes pada volume I poin malnutrition-related diabetes mellitus (E12) yang menyatakan kode ini sudah termasuk didalamnya malnutrition-related diabetes mellitus (insulin-dependent dan non-insulin-dependent). Sehingga kode unspecified protein-energy malnutrition (E46) tidak perlu di koding terpisah. Digit angka terakhir dari kode E12 tetap disesuaikan dengan jenis komplikasinya sesuai yang tertera pada ICD.
Perhatian Khusus	:	Perhatikan skor gizi, pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya.

50

Diagnosa	:	DM dengan AKI
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari sub bab renal failure (N17-N19) dengan NIDDM (E11) baik dari volume I maupun III. Kode DM with nephropathy dapat digunakan untuk menjelaskan diabetic nephropathy yang sudah tegak secara medis. Namun diperlukan rekomendasi dari perhimpunan profesi mengenai definisi dan kriteria penegakan diagnosis diabetic nephropathy.

Perhatian Khusus : Penggunaan kode kombinasi E11.2 yang direkomendasikan SPI pada kasus ini tidak bersifat mutlak mengingat ada AKI yang bukan karena DM, harus dilihat kasus per kasus dan perlu konfirmasi DPJP.

51

Diagnosa : E11.5 (sebagai koding kombinasi untuk diagnosa DM dan Ulkus dekubitus)

Prosedur : -

Aspek Koding : Jika ulkus dikoding bersamaan dengan diagnosa DM saja (hanya terdapat diagnosa DM) maka ulkus yang dikoding masuk dalam kode kombinasi E11.5 (ulkus yang terjadi dipicu oleh faktor penyakit DM).

Perhatian Khusus : Ulkus dekubitus yang dipicu oleh faktor selain DM memiliki kode tersendiri, yaitu L89.

52

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk diagnosa Unspecified diabetes mellitus with neurological complications (E14.4) dengan Diabetic polyneuropathy (G63.2), unspecified menjadi Unspecified diabetes mellitus with neurological complications (E14.4)

Prosedur : -

Aspek Koding : Pengkodean sistem dagger (†) dan asterisk (*) Jika diagnosis utama yang ditegakkan dokter dalam ICD 10 menggunakan kode dagger dan asterisk maka yang dikode sebagai diagnosis

utama adalah kode dagger, sedangkan kode asterisk sebagai diagnosis sekunder

Polyneuropathy (peripheral) G62.9
- in (due to)
- - diabetes (see also E10-E14 with fourth character .4) E14.4† G63.2* (ICD 10 Vol. 3)

Perhatian Khusus : Diagnosa polineuropati diabetik dikode dagger asterisk dengan E14.4† G63.2*

53

Diagnosa : Penggunaan kode dagger dan asterix hanya di kode salah satu yang merupakan main condition saja

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai kaidah koding, kode asterisk dan dagger dikoding secara bersamaan. Kode dagger sebagai diagnosa utama, dan asterisk sebagai diagnosa sekunder. Pada kondisi diagnosa utama adalah kode selain kode asterisk dagger, maka kedua kode asterisk dan dagger dikoding sebagai diagnosa sekunder. (Permenkes 76 tahun 2016)

Perhatian Khusus : dagger dan asteris adalah kode dual classification.

54

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal comps dengan End-stage renal disease menjadi Non-insulin-dependent diabetes mellitus with renal comps.

Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Pada kaidah morbiditas ICD 10 (volume I dan III) tidak ada hubungan includes / excludes secara langsung dari kode chronic kidney disease (N18) dengan NIDDM (E11). Kode DM with nephropathy dapat digunakan untuk menjelaskan diabetic nephropathy yang sudah tegak secara medis.
Perhatian Khusus	:	Hasil audit SPI tidak bersifat mutlak karena ada CKD yang bukan karena DM, harus dilihat kasus per kasus dan perlu konfirmasi DPJP.

55

Diagnosa	:	Kode diagnosa diabetes mellitus dengan komplikasi multipel dan AKI RS : Other specified diabetes mellitus with multiple complications (E13.7) dan Acute renal failure, unspecified (N17.9).
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari sub bab renal failure (N17-N19) dengan Diabetes (E10 - E14) baik dari volume I maupun III. Kode DM with nephropathy dapat digunakan untuk menjelaskan diabetic nephropathy yang sudah tegak secara medis. Namun diperlukan rekomendasi dari perhimpunan profesi mengenai definisi dan kriteria penegakan diagnosis diabetic nephropathy. Hasil audit SPI tidak mutlak karena ada AKI yang bukan karena DM, harus dilihat kasus per kasus dan perlu konfirmasi DPJP.

Perhatian Khusus	:	Tidak ada kode kombinasi antara diagnosa diabetes mellitus dan gagal ginjal akut (AKI)

56

Diagnosa	:	Lipoprotein deficiency (E78.6)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Digunakan pada kondisi: Abetalipoproteinamia High-density lipoprotein deficiency Hypoalphalipoproteinaemia Hypobetalipoproteinaemia (familial) Lecithin cholesterol acyltransferase deficiency Tangier disease Perhatikan pada kategori E78 Excludes : Sphingolipidosis (E75.0-E75.3)
Perhatian Khusus	:	-

57

Diagnosa	:	Other disorders of lipoprotein metabolism (E78.8)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	E78.8 Other disorders of lipoprotein metabolism Perhatikan pada kategori E78 Excludes : sphingolipidosis (E75.0-E75.3)
Perhatian Khusus	:	-

V. Kelainan Jiwa dan Tingkah Laku

58

Diagnosa	:	Schizoprenia (F20.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	F20.0 Paranoid schizopherenia Excludes : Involutional paranoid state (F22.8) paranoid (F22.0)
Perhatian Khusus	:	Terdapat variasi kode dan penjelasan untuk masing-masing kode pada ICD 10 volume 1.

VI. Penyakit-Penyakit Sistem Sirkulasi

59

Diagnosa	:	Hipertensi (I10)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Exclude pada sub bab: complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O11, O13-O16) involving coronary vessels (I20-I25) neonatal hypertension (P29.2) pulmonary hypertension (I27.0) Include pada kategori : High blood pressure Hypertension (arterial)(benign)(essential) (malignant)(primary)(systemic) Exclude pada kategori : involving vessels of: brain (I60-I69) eye (H35.0)
Perhatian Khusus	:	Perhatikan kode kombinasi pada kasus-kasus yang disebabkan oleh hipertensi. contoh : Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure (I11.0).

60

Diagnosa	:	Penggunaan kode kombinasi untuk Essential (primary) hypertension (I10) dengan Acute renal failure, unspecified menjadi Hypertensive renal

disease with renal failure

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai dengan instruksi includes pada volume I sub bab hypertensive renal disease (I12) yang menyatakan hanya any condition in N00–N07, N18.-, N19 or N26 due to hypertension dan juga tidak ada instruksi lain di volume III. Sehingga penggunaan kode acute renal failure, unspecified (N17.9) tidak bisa digabung dengan essential (primary) hypertension (I10) menjadi I12.

Perhatian Khusus : Diperlukan rekomendasi dari organisasi profesi mengenai matriks penegakan diagnosis antara acute dan chronic renal failure.

61

Diagnosa : Diagnosa utama Hipertensi dengan gagal ginjal disertai atau tidak disertai gagal jantung. Diagnosa sekunder : edem paru

Prosedur : -

Aspek Koding : Sesuai kaidah koding, Hipertensi dengan gagal ginjal yang disertai gagal jantung, maka udem paru tidak dikoding terpisah dan dikode I13.2. Jika diagnosis utama hipertensi dengan gagal ginjal maka dikode I12.0 dan Udem paru (J81) dikode tersendiri. Walaupun secara klinis, udem paru merupakan bagian dari tanda dan gejala dari acute on Chronic renal failure (overload syndrome)

Perhatian Khusus : Kriteria Pulmonary Oedema: gejala klinis sesak, takikardi, ronki

Ada penatalaksanaan pulmonary oedema yang terekam dalam resume medis dan ada terapi diuretik dan oksigen yang diberikan.

62

Diagnosa : HHD with CHF (I11.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : Kriteria ekslusi:
complicating pregnancy, childbirth and the puerperium (O10-O11, O13-O16)
involving coronary vessels (I20-I25)
neonatal hypertension (P29.2)
pulmonary hypertension (I27.0)

Kriteria eksklusi kategori I50:
Komplikasi dari aborsi atau kehamilan ektopic/ mola (O00-O07, O08.8) ;
prosedur dan operasi kebidanan (O75.4)
akibat hypertension (I11.0)
dengan renal disease (I13.-)
Setelah operasi cardiac atau akibat protesa cardiac (I97.1)
neonatal cardiac failure (P29.0)

Kriteria Inklusi:
Kondisi pada I50.-, I51.4-I51.9 yang disebabkan oleh hipertensi.

Perhatian Khusus : -

63

Diagnosa	:	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure (I11.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I11.9 Hypertensi heart disease without (congestive) heart failure Hypertensi heart disease NOS Perhatikan pada kategori I11 includes : any condition in I50,-, I51.4-I51.9 due to hypertensi
Perhatian Khusus	:	-

64

Diagnosa	:	Hypertensive renal disease with renal failure (I12.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I12.0 Hypertensi renal disease with renal failure Hypertensi renal failure Perhatikan pada kategori I12 includes : any condition in N00-N07, N18,-,N19 or N26 due to hypertensi arteriosclerosis of kidney arteriosclerotic nephritis (chronic) (interstitial) hypertensive nephropathy nephrosclerosis excludes : secondary hypertension I15,- Exclude pada sub bab I10-I15: complicating pregnancy, childbirth and the

puerperium (O10-O11, O13-O16)
involving coronary vessels (I20-I25)
neonatal hypertension (P29.2)
pulmonary hypertension (I27.0)

Perhatian Khusus : -

65

Diagnosa : Kombinasi diagnosis Primary pulmonary hypertension (I27.0) dengan Heart failure, unspecified (I50.9) menjadi kode I12;I12.0;I13;I13.1;I13.2; atau I13.9

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada instruksi include dan exclude pada ICD 10 tahun 2010. Sehingga kode I27.0 dan I50.9 dikoding terpisah.

Perhatian Khusus : Pastikan tatalaksana dilakukan untuk kedua penyakit tersebut.

66

Diagnosa : Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere (I43.8)

Prosedur : -

Aspek Koding : I43.8 Cardiomyopathy in other diseases classified elsewhere* merupakan kode asterisk dengan kode dagger :
Gouty tophi of heart (M10.0†)
Thyrotoxic heart disease (E05.9†)

Perhatian Khusus : -

67

Diagnosa	:	Atrioventricular block, complete (I44.2)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I44.2 Atrioventricular block, complete Termasuk kondisi: Complete heart block NOS Third-degree block
Perhatian Khusus	:	Pastikan penegakkan diagnosa pada hasil EKG

68

Diagnosa	:	Cardiac arrest, unspecified (I46.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I46.9 Cardiac arrest, unspecified Perhatikan pada sub bab : I46 Cardiac arrest Kecuali : cardiogeneic shock (R57.0) complicating : - abortion or molar pregnency (O00-O07, O08.8) - obstetric surgenry and procedures (O075.4)
Perhatian Khusus	:	1. Cardiac arrest dapat terjadi pada semua kasus (tidak hanya penyakit jantung) & ada bukti penatalaksanaan Cardiac Arrest yaitu CPR 2. Cardiac Arrest tidak dapat digunakan pada pasien DOA 3. Koding INA-CBG adalah kode Morbiditas

69

Diagnosa	:	Supraventricular tachycardia (I47.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I47.1 Supraventricular tachycardia Paroxysmal tachycardia: · atrial · atrioventricular [AV] · junctional · nodal Perhatikan pada sub bab I47 Paroxysmal tachycardia Kecuali : Komplikasi : - abortion orectopic or molar pregnancy (O00-O07,O08.8) - obstertic surgery and procedures (O75.4) tachycardia - NOS (R00.0) - sinoauricular NOS (R00.0) - sinus (sinusal) NOS (R00.0)
Perhatian Khusus	:	-

70

Diagnosa	:	Ventricular tachycardia (I47.2)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I47.2 Ventricular tachycardia Perhatikan pada sub bab I47 Paroxysmal tachycardia Kecuali : Komplikasi : - abortion orectopic or molar

pregnancy (O00-O07,O08.8)
- obstertic surgery and procedures (O75.4)
tachycardia
- NOS (R00.0)
- sinoauricular NOS (R00.0)
- sinus (sinusal) NOS (R00.0)

Perhatian Khusus : -

71

Diagnosa : Congestive Heart Failure (I50.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : Include:
- Congestive heart disease
- Right ventricular failure (secondary to left heart failure)

Exclude kategori:
Heart Failure dengan komplikasi:
abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8)
obstetric surgery and procedures (O75.4)
due to hypertension (I11.0)
with renal disease (I13.-)
following cardiac surgery or due to presence of cardiac prosthesis (I97.1)
neonatal cardiac failure (P29.0)

Perhatian Khusus : Apabila sudah ditemukan tanda-tanda edema paru dan CHF menggunakan kode tunggal I50.1

72

Diagnosa	:	Left ventricular failure (I50.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Include: Cardiac asthma Left heart failure Oedema of lung,- with mention of heart disease NOS or heart failure Pulmonary oedema,-with mention of heart disease NOS or heart failure Exclude kategori: Heart Failure dengan komplikasi: abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07, O08.8) obstetric surgery and procedures (O75.4) due to hypertension (I11.0) with renal disease (I13.-) following cardiac surgery or due to presence of cardiac prosthesis (I97.1) neonatal cardiac failure (P29.0)
Perhatian Khusus	:	-

73

Diagnosa	:	intracerebral haemorrhage, unspecified (I61.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	I61.9 Intracerebral haemorrhage, unspecified Includes : with mention of hypertension

(conditions in I10 and I15,-)
Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.

Perhatikan pada kategori I61
Excludes : sequelae of intracerebral haemorrhage (I69.1)

Kondisi perdarahan otak yang disebabkan oleh trauma eksternal gunakan kode : traumatic intracranial haemorrhage (S06,-)

Perhatian Khusus : -

74

Diagnosa : Cerebral Infarction (I63)

Prosedur : -

Aspek Koding : Kriteria inklusi kategori I63:
Oklusi dan stenosis arteri cerebral dan precerebla yang menyebabkan cerebral infarction.

Kriteria eksklusi kategori I63:
sequelae of cerebral infarction (I69.3)

Kriteria Inklusi Sub bab I60-I69 :
Jika disertai hipertensi (conditions in I10 and I15.-) dapat menggunakan kode tambahan (Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.)

Kriteria eksklusi Sub Bab I60-I69 :
transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45.-)
traumatic intracranial haemorrhage (S06.)
vascular dementia (F01.-)

Perhatian Khusus	:	Hasil imaging (Contoh CT scan) diperhatikan untuk penegakan tambahan jenis Stroke hemorrhagic atau non hemorrhagic. I63.- jika hasil pemeriksaan CT Scan (+) infark. Sequelae adalah suatu gejala “”late effect”” atau gejala yang menyerupai, atau gejala yang menetap satu tahun atau lebih setelah onset serangan.

75

Diagnosa	:	Stroke, not specified as haemorrhage or infarction (I64)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kriteria Inklusi Sub bab I60-I69 : Jika disertai hipertensi (conditions in I10 and I15.-) dapat menggunakan kode tambahan (Use additional code, if desired, to identify presence of hypertension.) Kriteria eksklusi Sub Bab I60-I69 : transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes (G45.-) traumatic intracranial haemorrhage (S06.) vascular dementia (F01.-)
Perhatian Khusus	:	Kode ini digunakan hanya untuk kasus stroke yang tidak spesifik apakah infark atau perdarahan. Pastikan pemeriksaan penunjang, klinis dan scoring. Perhatikan kode sequelae (I69). Sequelae adalah suatu gejala “”late effect”” atau gejala yang menyerupai, atau gejala yang menetap

satu tahun atau lebih setelah onset serangan.

Pastikan jika riwayat stroke lama menggunakan kode I69.-

I60.- jika perdarahan subarachnoid, I61,- jika perdarahan intracerebral, I62.- jika perdarahan lain di otak.

VII. Penyakit-Penyakit Sistem Pernafasan

76

Diagnosa : Acute pharingitis (J02.9)

Prosedur : -

Aspek Koding : J02.9 Acute pharyngitis, unspecified
Pharyngitis (acute):
- NOS
- gangrenius
- infective NOS
- suppurative
- ulcerative

Sore throat (acute) NOS

Perhatikan pada kategori J02
include : acute sore throat
ekslude : abscess :
- peritonsillar J36
- pharyngeal J39.1
- retropharyngeal J39.0

acute laryngopharyngitis J06.0
chronic pharyngitis J31.2

Perhatian Khusus : -

77

Diagnosa : Acute upper respiratory infection, unspecified (J06.9)

Prosedur : -

Aspek Koding : J06.9 Acute upper respiratory infection, unspecified
termasuk didalamnya :
Upper respiratory :
- disease, acute
- infection NOS

Eksklusi : acute respiratory infection NOS (J22)
influenza virus :
- identified (J09, J10.1)
- not identified (J11.1)

Perhatian Khusus : Perhatikan pada sub bab J00-J06
Eksklusi : chronic obstructive pulmonary disease wuth acute exacerbation NOS J44.1

Contoh : Jika terdapat kondisi akut ekseserbasi (contoh: infeksi saluran pernapasan akut) yang disertai dengan PPOK maka cukup menggunakan kode J44.1

78

Diagnosa : Pneumonia, unspecified (J18.-)

Prosedur : -

Aspek Koding : Kode ini hanya untuk kasus pneumonia yang tidak spesifik organisme penyebabnya.

Kriteria eksklusi:
Abscess of lung with pneumonia (J85.1)
Drug-induced interstitial lung disorders (J70.2-J70.4)
Pneumonitis, due to external agents (J67-J70)
Pneumonia: aspiration (due to):

NOS (J69.0)
anaesthesia during:
labour and delivery (O74.0)
pregnancy (O29.0)
puerperium (O89.0)
neonatal (P24.9)
solids and liquids (J69.-)
congenital (P23.9)
interstitial NOS (J84.9)
lipid (J69.1)
usual interstitial (J84.1)

Kode kombinasi untuk bronchopneumonia/ Pneumonia dengan PPOK : J44.0

Perhatian Khusus : Kode pneumonia dengan organisme penyebab spesifik ada pada J12-J17

Pneumonia dapat didiagnosis sesuai dengan KMK RI No. HK. 02.02/MENKES/514/2015 yaitu jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala dibawah ini :

1. Batuk-batuk bertambah
2. Perubahan karakteristik dahak / purulen
3. Suhu tubuh > 38°C (aksila) / riwayat demam
4. Pemeriksaan fisik : ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki
5. Leukosit > 10.000 atau < 4500

79

Diagnosa	:	Pneumonia dengan PPOK J18.9 dan J44.0
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Lebih tepat menggunakan kode kombinasi J44.0. Sesuai dengan instruksi pada volume III yang menyatakan disease - lung - obstructive (chronic) - with lower respiratory infection (except influenza) mengarah pada kode chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0).
Perhatian Khusus	:	Kode J44.0 sudah menggambarkan PPOK dengan infeksi sekunder saluran napas bawah termasuk didalamnya pneumonia yang tidak perlu dikoding terpisah.

80

Diagnosa	:	Pneumonia dengan PPOK Eksaserbasi
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	ICD10 2010 Volume 3 Disease, diseased------continued - lung J98.4 - - interstitial J84.9 - - - specified NEC J84.8 - - obstructive (chronic) J44.9 - - - with - - - - exacerbation NEC (acute) J44.1 Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung pada kode chronic obstructive pulmonary

disease with acute exacerbation, unspecified (J44.1) dengan pneumonia, unspecified (J18.9). Tidak ditemukan juga kaidah kode kombinasi antara J44.1 dan J18.9.
Berdasarkan pembahasan tim tarif Kemenkes dengan Persatuan profesi, keadaan akut ekserbasi dan pneumonia merupakan dua keadaan yang berbeda dan membutuhkan tata laksana tersendiri, sehingga dikoding terpisah.

Perhatian Khusus : Tidak ada kode kombinasi antara kode diagnosa Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified (J44.1) dan pneumonia dengan kode pneumonia ditentukan apakah ada kode kombinasi terhadap diagnosa lain (kaidah koding)

81

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Septicaemia, unspecified menjadi Septicaemia due to Streptococcus pneumoniae

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan septicaemia, unspecified (A41.9) baik dari volume I maupun III.

Perhatian Khusus : Kode septicaemia due to streptococcus pneumoniae (A40.3) digunakan apabila sudah tegak ditemukan kuman streptococcus pneumoniae pada penunjang medis.

82

Diagnosa	:	Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Typhoid fever menjadi Localized salmonella infections (A02.2)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	ICD 10 2010 Volume 3 Typhoid (abortive) (ambulant) (any site) (fever) (hemorrhagic) (infection) (intermittent) (malignant) (rheumatic) A01.0 - inoculation reaction — see Complications, vaccination - pneumonia A01.0† J17.0* Sesuai dengan intruksi pada volume I sub bab pneumonia in diseases classified elsewhere (J17) yang menyatakan penggunaan pneumonia (due to)(in) · typhoid fever mengarah kode dagger (A01.0+) dan asterisk (J17.0*). Bukan kode kombinasi.
Perhatian Khusus	:	Diagnosa demam tifoid dan pneumonia dikode dengan dagger asterisk dengan A01.0+ dan J17.0* Penegakan diagnosa pneumonia lihat lampiran Bab Medis poin no. 3 Penggunaan kode A01.0 atau A02.2 ditentukan berdasarkan jenis kuman, pada kondisi adanya pneumonia, menggunakan kode asterisk J17.0*

83

Diagnosa : Kombinasi diagnosa Pneumonia, unspecified (J18.9) dan HIV disease resulting in candidiasis (B20.4)

Prosedur : -

Aspek Koding : ICD 10 2010 Volume 3

Multiple, multiplex — see also condition
- birth, affecting fetus or newborn P01.5
- delivery — see Delivery, multiple
- digits (congenital) Q69.9
diseases NEC, resulting from HIV
disease B22.7
- infections, resulting from HIV disease B20.7

Perhatian Khusus : Dikode HIV disease resulting in multiple infections (B20.7) sebagai diagnosis utama, HIV disease resulting in candidiasis (B20.4) dan HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases (B20.8) sebagai diagnosis sekunder

84

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk Pneumonia, unspecified dengan Asthma, unspecified menjadi Chronic obstruct pulmonary disease with acute lower respiratory infection

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode pneumonia, unspecified (J18.9) dengan asthma (J45) baik dari volume I maupun III. Kedua kode tidak dapat dikombinasi.

Perhatian Khusus	:	Kode chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.0) digunakan untuk menjelaskan PPOK dengan infeksi saluran napas bawah yang tegak secara medis, bukan untuk asthma

85

Diagnosa	:	Kode kombinasi N18.9 dengan N39.0 menjadi N13.6
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Pada volume I dan III tidak ada keterangan untuk kode kombinasi antara N18.9 dan N39.0. Kedua kode tersebut tidak ada hubungan include exclude dengan N13.6. Sehingga tidak dapat dijadikan kode kombinasi
Perhatian Khusus	:	Kode N13.6 digunakan sebagai kode kombinasi hanya pada kode N13.0–N13.5 dan obstruktif uropati yang disertai infeksi.

86

Diagnosa	:	Bronchitis, not specified as acute or chronic (J40)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	J40 Bronchitis, not spesified Include : Bronchitis : - NOS - catarrhal - with tracheitis NOS Tracheobronchitis NOS Eksklusi pada sub bab:

cystic fibrosis (E84.-)
Eksklusi kategori :
bronchitis :
- allergic NOS (J45.0)
- Asthmatic NOS (J45.9)
- chemical (acute) (J68.0)

Perhatian Khusus : Perhatikan catatan dibawah kategori J40
Catatan : Bronchitis yang tidak spesifik antara akut atau kronik pada usia dibawah 15 tahun dapat diasumsikan sebagai kondisi akut dan dikode J20.-

87

Diagnosa : COPD/PPOK (J44.-)

Prosedur : -

Aspek Koding : Perhatikan pada kategori J44 Other chonic obstructive pulmonary disease
include : chronic :
- bronchitis :
-asthmatic (obstructive)
- emphysematous
- with :
- airways obstruction
- emphysema
- obstructive :
- asthma
- bronchitis
- tracheobronchitis
eksklusi : asthma (j45,-)
asthmatic bronhitis NOS (J45.9)
bronchiectasis (J47)

chronic :
- bronchitis :
- NOS (J42)
- simple and mucopurulent (J41,-)
- tracheitis (j42)
- tracheobronchitis (J42)
emphysema (J43,-)
lung disease due to external agents (J60-J70)

Perhatian Khusus : ICD 10 tahun 2010 Volume 3
Disease, diseased------
- lung J98.4
- - obstructive (chronic) J44.9
- - - with
- - - - exacerbation NEC (acute) J44.1
- - - - lower respiratory infection
(except influenza) J44.0
Kode J44.0 sudah menggambarkan PPOK dengan infeksi sekunder saluran napas bawah termasuk didalamnya pneumonia yang tidak perlu dikoding terpisah

88

Diagnosa : Asthma (J45)

Prosedur : -

Aspek Koding : Kriteria ekslusi:
acute severe asthma (J46)
chronic asthmatic (obstructive) bronchitis (J44.-)
chronic obstructive asthma (J44.-)
eosinophilic asthma (J82)
lung diseases due to external agents (J60-J70)

status asthmaticus (J46)
J45.0 Predominantly allergic asthma
Allergic:
bronchitis NOS
rhinitis with asthma
Atopic asthma
Extrinsic allergic asthma
Hay fever with asthma
J45.1 Nonallergic asthma
Idiosyncratic asthma
Intrinsic nonallergic asthma
J45.8 Mixed asthma
Combination of conditions listed in J45.0 and J45.1
J45.9 Asthma, unspecified
Asthmatic bronchitis NOS
Late-onset asthma

Perhatian Khusus : -

89

Diagnosa : Effusi pleura (J90)

Prosedur : -

Aspek Koding : Eksklusi : Effusi Pleura dengan kondisi :
chylous (pleural) effusion J94.0
pleurisy NOS R09.1
tuberculous A15-A16
Malignan C78.2
Influenza J11.1
pada fetus, newborn P28.8

Perhatian Khusus : -

VIII. Penyakit-Penyakit Sistem Pencernaan

90

Diagnosa	:	Kista mandibula sinistra (K09.2), Gingivitis (K05.1), Gingival Abses (K05.2)
Prosedur	:	Eksterpasi kista
Aspek Koding	:	Untuk prosedur ekstirpasi yang dilakukan pada daerah ginggiva/gum/gusi maka menggunakan kode 24.31.
Perhatian Khusus	:	Pastikan lokasi dari ekstirpasi yang dilakukan.

91

Diagnosa	:	Gastritis (K29)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kriteria eksklusi kategori: eosinophilic gastritis or gastroenteritis (K52.8) Zollinger-Ellison syndrome (E16.4) Gastritis (sederhana) K29.7 Gastritis dengan perdarahan K29.71 (Gunakan kode ini jika ada muntah/BAB berdarah) Gastritis akut erosif K29.00 -- dengan perdarahan K29.01 Gastritis Tuberkulosa A18.83 Variasi kode K29,- berupa: K29.0 Acute haemorrhagic gastritis, Acute (erosive) gastritis with haemorrhage Excl.: erosion (acute) of stomach (K25.-) K29.1 Other acute gastritis

K29.2 Alcoholic gastritis
K29.3 Chronic superficial gastritis
K29.4 Chronic atrophic gastritis, Gastric atrophy
K29.5 Chronic gastritis, unspecified, Chronic gastritis:
antral, fundal
K29.6 Other gastritis, Giant hypertrophic gastritis
Granulomatous gastritis, Ménétrier disease
K29.7 Gastritis, unspecified

Perhatian Khusus : Penegakan diagnosis Gastritis setelah konfirmasi hasil pemeriksaan penunjang Endoskopi

92

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk Gastritis, unspecified dengan Haematemesis menjadi Acute haemorrhagic gastritis

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode hematemesis (K92.0) dengan gastritis (K29.7) baik dari volume I maupun III. Kode acute haemorrhagic gastritis (K29.0) digunakan apabila sudah dilakukan konfirmasi sumber perdarahan berasal dari gastritis yang tegak secara medis.

Perhatian Khusus : -

93

Diagnosa : Dyspepsia (K30)

Prosedur : -

Aspek Koding : Exclude :
dyspepsia dengan penyebab
nervous (F45.3)
neurotic (F45.3)
psychogenic (F45.3)
heartburn (R12)

Perhatian Khusus : Penegakan diagnosis Dispepsia bisa dengan gejala klinis. Sebelum ada pemeriksaan penunjang seperti endoskopi, diagnosis yang tegak adalah Dispepsia (K30). Jika dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diagnosis disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang.Indikasi untuk dilakukan endoskopi pada kasus Dispepsia dengan alarm symptom seperti : berat badan menurun, tidak bisa menelan, demam, perdarahan atau ketersediaan sarana dan prasarana.

94

Diagnosa : Acute appendicitis (K35.8)

Prosedur : -

Aspek Koding : K35.2
Acute appendicitis with generalized peritonitis
Appendicitis (acute) with generalized (diffuse) peritonitis following rupture or perforation
K35.3
Acute appendicitis with localized peritonitis
Acute appendicitis with localized peritonitis with or without rupture or perforation
Acute appendicitis with peritoneal abscess
K35.8

Acute appendicitis, other and unspecified
Acute appendicitis without mention of localized or generalized peritonitis

Perhatian Khusus : Kondisi peritonitis dan atau perforasi, abses peritoneal yang disertai apendisitis (ataupun kondisi sebaliknya) cukup menggunakan kode gabungan K35.-

95

Diagnosa : Kode kombinasi diagnosa primer Hernia dengan diagnosa sekunder obstruksi

Prosedur : -

Aspek Koding : Pada sub bab Hernia (K40-K46) sudah terdapat kode untuk hernia yang disertai obstruksi. Obstruksi tidak dapat digunakan sebagai diagnosa sekunder.

Perhatian Khusus : -

96

Diagnosa : Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene
(K40.9)

Prosedur : -

Aspek Koding : Hernia dengan gangren dan obstruksi diklasifikasikan hernia dengan gangren.

Kriteria inklusi sub bab:
Hernia yang didapat (acquired),
congenital (kecuali diafragmatik atau hiatus),
rekuren (berulang).

Includes: bubonocele, inguinal hernia (direk, indirek, double, oblique,NOS) , scrotal hernia

Perhatian Khusus : Pastikan lokasi anatomis hernia sesuai dengan kode yang digunakan.

97

Diagnosa : Other and unspecified cirrhosis of liver (K74.6)

Prosedur : -

Aspek Koding : K74.6 Other and unspecified cirrhosis of liver
Cirrhosis (of liver) :
- NOS
- cryptogenic
- Macronodular
- Mixed type
- portal
- postnecrotic

Perhatikan pada kategori K74 Fibrosis and cirrhosis of liver
Excludes : alcoholic fibrosis of liver (K70.2)
cardiac sclerosis of liver (K76.1)
cirrhosis (of liver) :
- alcoholic (K70.3)
- congenital (P78.8)
with toxic liver disease (K71.7)

Perhatian Khusus : -

IX. Penyakit Kulit dan Jaringan Subkutis

98

Diagnosa	:	Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle of limb (L02.4)
Prosedur	:	Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn (86.28); Other incision of skin and subcutaneous tissue (86.09)
Aspek Koding	:	Jika insisi pada abses maka menggunakan 86.04 (Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue).
Perhatian Khusus	:	-

99

Diagnosa	:	Decubitus ulcer (L89) dengan Non-insulin-depend diabetes mellitus without complication
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Apabila ulkus pada NIDDM maka di kode E11.5 Non-insulin-dependent diabetes mellitus, with peripheral circulatory complications). Ulkus dekubitus yang dipicu oleh faktor selain DM memiliki kode tersendiri, yaitu L89.
Perhatian Khusus	:	-

100

Diagnosa	:	Ulkus Thorax Dextra (L98.4)
Prosedur	:	Debridement dan Eksisi luas

Aspek Koding	:	Jika eksisi yang dilakukan bagian dari debridement tajam (membuang jaringan nekrotik) maka menggunakan kode 86.22 (Excisional debridement of wound, infection, or burn)
Perhatian Khusus	:	Pastikan prosedur yang dilakukan.

101

Diagnosa	:	Kista temporoparietal
Prosedur	:	Eksisi
Aspek Koding	:	Kode diagnosis G93.0 merupakan kode untuk kista lokasi pada struktur otak. Jika kista berada pada kulit kepala maka menggunakan kode L72.9 Jika eksisi dilakukan untuk mengambil jaringan maka menggunakan kode 86.3, namun jika dilakukan eksisi dan biopsi maka menggunakan kode 86.11
Perhatian Khusus	:	Pastikan lokasi kista dan prosedur yang dilakukan.

X. Penyakit-Penyakit Sistem Genitourinarius

102

Diagnosa	:	Hidronefrosis, Batu Saluran Kemih dan ISK dikoding kombinasi dengan kode N13.6 RS : Diagnosis N132 Diagnosis N390
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I kode hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction (N13,2) yang menyatakan with infection mengarah pada kode pyonephrosis (N13.6). Sehingga penggunaan kode N13,6 digunakan untuk menggabungkan antara hydronephrosis, batu kidney - ureter dengan ISK.
Perhatian Khusus	:	-

103

Diagnosa	:	Diagnosa primer hidronefrosis yang disertai dengan urolitiasis (batu saluran kemih) atau infeksi saluran kemih
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Menggunakan kode kombinasi pyonephrosis (N13.6). Urolitiasis dan infeksi saluran kemih tidak dikode sebagai diagnosa sekunder
Perhatian Khusus	:	-

104

Diagnosa	:	Penggunaan kode kombinasi untuk diagnosa Other obstructive and reflux uropathy (N13.8) dengan Urinary tract infection, site not specified (N39.0), unspecified menjadi Pyonephrosis (N13.6)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	N13.6 Pyonephrosis Conditions in N13.0-N13.5 with infection Obstructive uropathy with infection Use additional code (B95-B97), if desired, to identify infectious agent.
Perhatian Khusus	:	Sesuai ICD 10 2010 Volume 1, diagnosa Other obstructive and reflux uropathy (N13.8) dengan Urinary tract infection, site not specified (N39.0) dikode terpisah

105

Diagnosa	:	Penggunaan kode kombinasi untuk Acute Renal Failure (N17.9) dengan Urinary tract infection, site not specified menjadi Pyonephrosis
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Tidak ada instruksi includes / excludes pada kode acute renal failure, unspecified (N17.9) dengan kode urinary tract infection, site not specified (N39.0) baik di volume I maupun III. Bukan kode kombinasi.
Perhatian Khusus	:	-

106

Diagnosa	:	AKI dan Sirosis Hepatis dikoding kombinasi dengan kode K76.7 RS : Diagnosis N179 Diagnosis K746 SPI : Kombinasi K767
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung pada kode acute renal failure, unspecified (N17.9) dan other unspecified cirrhosis of liver (K74.6) baik dari volume I maupun III. Sedangkan kode hepatorenal syndrome (K76.7) digunakan untuk sindrom hepatorenal yang tegak secara medis. Bukan kode kombinasi.
Perhatian Khusus	:	-

107

Diagnosa	:	Calculus of kidney (N20.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	N20.0 Calculus of kidney termasuk didalamnya: Nephrolithiasis NOS Renal calculus or stone Stagghon calculus Stone in kidney Perhatikan pada kategori N20 Includes : calculus pyelonephiritis Excludes : with hydronephrosis (N13.2) -with infection (N13.6)

Sesuai dengan instruksi excludes pada ICD 10 2008 dan 2010 volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23). Kondisi infeksi pada urinary calculus tidak menggunakan kode tersendiri. Cukup dikode urinary calculus sebagai diagnosa utama (tanpa diagnosa sekunder)

Perhatian Khusus : Kondisi batu saluran kemih dan batu ginjal yang disertai hidronefrosis dan infeksi menggunkan kode N13.6
Kondisi batu saluran kemih yang disertai dengan infeksi salurah kemih menggunakan kode gabungan di N20-N23 (sesuai kriteria eksklusi di sub bab N30-N39)

108

Diagnosa : Kode kombinasi N20.1 dan N10 digabung menjadi N20.1

Prosedur : -

Aspek Koding : ICD 10 2010 Volume 3
Pyelonephritis (see also Nephritis, tubulo-interstitial) N12
- acute N10
Kode calculus of ureter (N20.1) dan pyelonephritis (N10) lebih tepat digabung menggunakan kode N20.9. Sesuai instruksi volume III pyelonephritis (N10) - calculous mengarah kepada kode urinary calculus, unspecified N20.9. Sehingga kode N20.9 sudah menggambarkan adanya batu kidney - ureter

yang disertai pyelonephritis.

Perhatian Khusus : -

109

Diagnosa : Calculus of Kidney and Ureter (N20.2) yang disertai dengan penyakit infeksi saluran kemih (N39.0) lebih tepat dikode hanya N20.2

Prosedur : -

Aspek Koding : ICD 10 2010 Volume 1
Other diseases of urinary system
(N30-N39)
Excludes: urinary infection (complicating):
· abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07 , O08.8)
· pregnancy, childbirth and the puerperium (O23.- , O75.3 , O86.2)
· with urolithiasis (N20-N23)

Perhatian Khusus : Kondisi infeksi pada calculus of kidney and ureter tidak menggunakan kode tersendiri. Cukup dikode N20.2. Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23).

110

Diagnosa : Rekomendasi SPI mengenai perubahan kode Calculus of Kidney and Ureter (N20.2) menjadi Pyonephrosis (N13.6) pada diagnosa sekunder AKI (N17.9)

Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	ICD 10 2010 Volume 3 Calculus, calculi, …----- - ureter (impacted) (recurrent) N20.1 - - with - - - calculus, kidney N20.2 - - - - with hydronephrosis N13.2 - - - - - with infection N13.6
Perhatian Khusus	:	"Calculus ureter dan ginjal (N20.2) tidak dapat di kode sebagai Pyonephrosis (N13.6) jika tidak terdapat diagnosa hydronephrosis dan infeksi. Diagnosa dikode terpisah. Perlu diperhatikan penegakan diagnosa gagal ginjal akut (lihat lampiran pada bab medis poin no 5, Kriteria Gagal Ginjal Akut)

111

Diagnosa	:	Calculus in bladder (N21.0) yang disertai dengan penyakit infeksi saluran kemih (N39.0) lebih tepat dikode hanya N21.0
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Other diseases of urinary system (N30-N39) Excludes: urinary infection (complicating): · abortion or ectopic or molar pregnancy (O00-O07 , O08.8) · pregnancy, childbirth and the puerperium (O23.- , O75.3 , O86.2) · with urolithiasis (N20-N23)

Perhatian Khusus : Kondisi infeksi pada Calculus in bladder tidak menggunakan kode tersendiri. Cukup dikode N21.0. Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other diseases of urinary system (N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23).

112

Diagnosa : Kasus Batu Buli (N21.0) dan Hidronefrosis dikoding N20.9
RS : Diagnosis N210 Diagnosis N132
SPI : Kombinasi N209

Prosedur : -

Aspek Koding : Tidak ada instruksi includes / excludes pada kode calculus in bladder (N21.0) dengan kode hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction (N13.2) baik di volume I dan III. Kode urinary calculus, unspecified (N20.9) merupakan bagian dari kode calculus of kidney and ureter (N20) sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan batu buli.

Perhatian Khusus : -

113

Diagnosa : Penggunaan kode kombinasi untuk Unspecified renal colic (N23) dengan Other and unspecified hydronephrosis menjadi Hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction

Prosedur : -

Aspek Koding : Colic------
renal N23
Tidak ada instruksi includes / excludes secara langsung dari kode unspecified renal colic (N23) dengan other and unspecified hydronephrosis (N13.3) baik dari volume I maupun III. Kode hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction (N13.2) digunakan apabila sudah ditemukan batu yang tegak secara medis.

Perhatian Khusus : Tidak ada kode kombinasi diagnosa kolik renal dengan hydronephrosis

114

Diagnosa : Urinary tract infection, site not specified (N39.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : Kriteria eksklusi sub bab:
Urinary infection (complicating):
Aborsi atau kehamilan ektopik/mola(O00-O07, O08.8)
Kehamilan, persalinan dan nifas (O23.-, O75.3, O86.2)
Dengan urolithiasis (jika diserta N39.0, hanya menggunakan kode N20-N23)
Kriteria eksklusi kategori:
haematuria (NOS (R31),
rekuren dan persisten (N02.-),
pada lesi dengan morfologi spesifik (N02.),
proteinuria NOS (R80)
Sesuai dengan instruksi excludes pada volume I sub bab other diseases of urinary system

(N30-N39) yang menyatakan urinary infection (complicating) with urolithiasis mengarah pada satu kode (N20-N23).

Perhatian Khusus : Kondisi batu saluran kemih yang disertai dengan infeksi salurah kemih menggunakan kode gabungan di N20-N23 (sesuai kriteria eksklusi di sub bab N30-N39)

115

Diagnosa : Hyperplasia of Prostate (N40)

Prosedur : -

Aspek Koding : N40 Hyperplasia of prostat
termasuk didalamnya :
Adenofibromatous hypertrophy of prostat
Enlargement (benign) of prostat
Hypertrophy (benign) of prostat
Median bar (prostate)
Prostatic obstruction NOS
Eksklusi : benign neoplasmas of protate (D29.1)

Perhatian Khusus : Pastikan kesesuaian dengan hasil pemeriksaan penunjang (histopatologis, dll)

116

Diagnosa : Kista vagina (N89.8)

Prosedur : Eksisi kista dan adhesiolisis

Aspek Koding : Jika prosedur yang dilakukan adalah eksisi pada vagina untuk mengangkat kista maka dikode 70.33. Jika prosedur yang dilakukan adalah mengambil jaringan untuk biopsi maka dikode 70.24.

Jika prosedur yang dilakukan adalah untuk mengangkat kista secara keseluruhan dan biopsi maka dikode 70.33 dan 70.24.

Perhatian Khusus : -

XI. Kehamilan, Melahirkan, dan Nifas

117

Diagnosa	:	Blighted ovum and nonhydatidiform mole (O02.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O02.0 Blighted ovum and nonhydatidiform mole Mole : - carneous - fleshy - intrauterine NOS Pathological ovum
Perhatian Khusus	:	Perhatikan pada kategori O02 Use additional code from category O08,-, if desired, to identify any associated complication Excludes : papyraceous fetus (O31.0)

118

Diagnosa	:	Spontaneous abortion, incomplete without complication (O03.4)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O03.4 Spontaneous abortion Inklusi : miscarriage Perhatikan pada sub bab (O00-O08) Eksklusi : continuing pregnancy in multiple gestation after abortion of one fetus or more (O31.1)
Perhatian Khusus	:	-

119

Diagnosa	:	Unspesified abortion incomplete (O06.4)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O06.4 Unspecified abortion incomplete, without complication Includes : induced abortion NOS Perhatikan pada sub bab (O00-O08) Exludes : continuing pregnancy in multiple gestation after abortion of one fetus or more (O31.1)
Perhatian Khusus	:	-

120

Diagnosa	:	Severe pre-eclampsia (O14.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O141 Severe pre-eclampsia Pada kategori O14 kriteria eksklusi : superimposed pre-eclampsia O11
Perhatian Khusus	:	Perhatikan kriteria penegakan diagnosis moderat dan severe pre-eclampsia Perhatikan jika sudah terdiagnosa hipertensi sebelum masa kehamilan, dan terdapat peningkatan kadar proteinuria selama masa kehamilan maka digunakan kode O11

121

Diagnosa	:	Mild hyperemesis gravidarum (O21.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O21.0 Mild hyperemesis gravidarum Hyperemesis gravidarum, mild or unspecified, starting before the end of the 22nd week of gestation Perhatikan pada sub bab (O20-O29) Eksklusi : - Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems (O30-O48) - Disease classifiable alsewhere but complicating pregnancy, labour and delivery, and the purperium (O98-O99)
Perhatian Khusus	:	-

122

Diagnosa	:	Maternal care for disproportion, unspecified (O33.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O33.9 Maternal care for disproportion, unspecified Cephalopelvic disproportion NOS Fetopelvic disproportion NOS Perhatikan pada kategori O33 Includes : the listed conditions as a reason for obsevation, hospitalization or other obstetric care of the mother, or for caesarean section before onset of labour Excludes : the listed conditions with obstructed labour (O65-O66)
Perhatian Khusus	:	-

123

Diagnosa	:	Maternal care due to uterine scar from previous surgery (O34.2)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O34.2 Maternal care for scar from previous caesarean section Excludes: vaginal delivery following previous caesarean section NOS (O75.7)
Perhatian Khusus	:	Perhatikan penunjang medis dan klinis

124

Diagnosa	:	Oligohydramnios (O41.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O41.0 Oligohydramnios Oligohydramnios without mention of rupture of membranes (O42,-) Perhatikan pada kategori O41. Excludes : premature rupture of membranes (O42,-) Jika terjadi oligohidroamnion dan ketuban pecah dini (KPD) maka hanya digunakan kode 042.-
Perhatian Khusus	:	-

125

Diagnosa	:	Prolonged pregnancy (O48)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	O48 Prolonged pregnancy Post-dates Post-term ICD 10 Volume 1 42 completed weeks or more (294 days or more) of gestation.
Perhatian Khusus	:	Perhatikan pada sub bab : O30-O48 Asuhan ibu sehubungan dengan masalah janin, amnion dan mungkin melahirkan Prolonged pregnancy (O48) termasuk dalam sub bab maternal care related to fetus and amniotic cavity and possible delivery problems. Tidak ada instruksi includes maupun excludes pada volume I dan III. Tidak ada aturan khusus di PMK 76. Kode O48 digunakan sesuai dengan standar kriteria klinis yang berlaku. Kriteria WHO (Volume II ICD-10 Revisi Tahun 2010) yaitu usia kehamilan 42 minggu atau lebih.

126

Diagnosa	:	Persalinan normal 080.9 dan O80.0
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kriteria inklusi: Kasus persalinan normal dengan bantuan minim atau tanpa bantuan sama sekali, dengan atau tanpa episiotomi.

Perhatian Khusus	:	Diagnosa penyulit/komplikasi menjadi diagnosa utama, metode persalinan normal menjadi diagnosa sekunder. Jika tidak ada penyulit/komplikasi maka metode persalinan normal menjadi diagnosa utama. Pada semua kasus persalinan harus ditambahkan kode Z37.- sebagai diagnosa sekunder.

127

Diagnosa	:	Persalinan Caesar (O82.-)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Gunakan kode spesifik yang sesuai dengan deskripsi ICD 10. Contoh : Operasi Sectio Cesarea elektif menggunakan kode O82.0 sedangkan untuk Operasi Sectio Cesarea emergensi menggunakan kode O82.1
Perhatian Khusus	:	Diagnosa penyulit/komplikasi menjadi diagnosa utama, metode persalinan sesar menjadi diagnosis sekunder. Pada semua kasus persalinan harus ditambahkan kode Z37.- sebagai diagnosis sekunder.

128

Diagnosa	:	Anemia pada kehamilan, persalinan, puerperium
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Jika dalam ICD 10 terdapat catatan “Use additional code, if desired, to identify specified condition” maka kode tersebut dapat digunakan sesuai

dengan kondisi pasien (Permenkes 76/2016)
ICD 10 2010 Volume 1
Anemia-------
- complicating pregnancy, childbirth or puerperium O99.0
O99 Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium
Note: This category includes conditions which complicate the pregnant state, are aggravated by the pregnancy or are a main reason for obstetric care and for which the Alphabetical Index does not indicate a specific rubricin Chapter XV.
Use additional code, if desired, to identify specific condition
O99.0 Anaemia complicating pregnancy, childbirth and the puerperium
Conditions in D50-D64

Perhatian Khusus : Anemia pada saat kehamilan atau persalinan harus menggunakan dua kode, yaitu O99.0 dan D64.9 yang dikoding sebagai diagnosa sekunder (Permenkes 76 tahun 2016)

129

Diagnosa : Pengkodean kondisi penyakit atau kelainan yang menyertai kehamilan atau persalinan

Prosedur : -

Aspek Koding : Kode O95 - O99 digunakan jika ada kondisi penyakit atau kelainan yang menyertai kehamilan atau persalinan

Perhatian Khusus : -

XII. Kondisi Tertentu Yang Dimulai Pada Periode Perinatal

130

Diagnosa	:	Bayi lahir dari persalinan dengan infeksi (P39.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	P39.9 adalah kode untuk Infeksi pada perinatal sehingga harus dibuktikan terjadinya infeksi bukan hanya terapi yang diberikan.
Perhatian Khusus	:	Pastikan tercatat dalam resume medis infeksi yang terjadi

131

Diagnosa	:	Neonatal jaundice, unspecified (P59.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	P59.9 Neonatal jaundice, unspecified Physiological jaundice (intense)(prolonged) NOS Perhatikan pada kategori Excludes : due to inborn errors of metabolism (E70-E90) kernicterus (P57.-)
Perhatian Khusus	:	-

XIII. Malformasi, Deformasi Dan Kelainan Kromosom Kongenital

132

Diagnosa : Atrial septal defect (Q21.1)

Prosedur : -

Aspek Koding : Q21.1 Atrial septal defect
Coronary sinus defect
Patent or persistent :
- foramen ovale
- ostium secundum defect (type II)
sinus venous defect
Perhatikan pada sub bab Q21 Congenital malformations of cardiac septa
Kecuali : acquired cardiac septal defect (I51.0)

Perhatian Khusus : -

133

Diagnosa : Tetralogy of fallot (Q21.3)

Prosedur : -

Aspek Koding : Q21.3 Tetralogy of fallot
vetricular septal defect yang disertai pulmonary stenosis atau atresia, dextroposition aorta dan hypertrophy ventrikel kanan.
Perhatikan pada sub bab Q21 Congenital malformations of cardiac septa
Kecuali : acquired cardiac septal defect (I51.0)

Perhatian Khusus : -

XIV. Gejala, Tanda, dan Hasil Abnormal Klinis Dan Laboratorium, Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain

134

Diagnosa	:	Bradycardia, unspecified (R00.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	R00.1 Bradycardia, unspesified Bradycardia : - simoatrial - sinus - vagal Slow heart beat Use additional external cause code (Chapter XX, if desired, to identify drug-induced) Perhatikan sub bab R00 Abnormalities of heart beat. Kecuali pada kondisi : Abnormalitas yang disebabkan pada masa perinatal gunakan kode P29.1 Aritmia yang sudah spesifik gunakan kode I47-I49.
Perhatian Khusus	:	-

135

Diagnosa	:	Gangrene, not elsewhere classified (R02)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	R02 Gangrene, not elsewhere classified Perhatikan pada sub bab R02 Ganrene, NEC

kecuali pada kondisi :
- atherosclerosis (I70.2)
- diabetes mellitus (E10-E14 with common fourth character. 5)
- other peripheral vascular disease (I73,-)
gangrene of certain specified sites
- see Alphabetical Index
gas gangrene (A48.0)
pyoderma gangrenosum (L88)

Perhatian Khusus : Sesuai kaidah ICD jika gangrene saja dapat dikode R02, Gas Gangrene dikode A48.0 dan gangrene pada DM diberi kode E10-E14 (sesuai dengan jenis DM) dengan digit terakhir .5 (contoh Gangrene DM Tipe 2 di kode E11.5). Pastikan bahwa hubungan gangren dengan DM.

136

Diagnosa : Epistaxis (R04.0)

Prosedur : -

Aspek Koding : R04.0 Epistaxis
Perdarahan dari rongga hidung.

Perhatian Khusus : Kondisi perdarahan yang terjadi pada kasus DHF harus dinyatakan sebagai diagnosis sekunder karena hal tersebut penting dalam menentukan penatalaksanaan selanjutnya, dan bukti pendukungnya adalah adanya penatalaksanaan perdarahan dalam rekam medis

137

Diagnosa : Haemoptysis (R04.2)

Prosedur : -

Aspek Koding : R04.2 Haemoptysis
Dahak disertai darah
Batuk berdarah

Perhatian Khusus : Perhatikan penyebab dari kondisi Hemoptisis. Jika merupakan bagian dari diagnosis utama maka tidak dikode sebagai diagnosis sekunder.
Contoh : Hemoptisis pada Tuberkulosis Paru cukup dikode dengan kode diagnosis Tuberkulosis Paru

138

Diagnosa : Respiratory arrest (R09.2)

Prosedur : -

Aspek Koding : R09.2 Respiratory arrest
Termasuk didalamnya : cardiorespiratory failure
Perhatikan pada sub bab
R09 Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
Kecuali : respiratory :
- distress (syndrome)(of) :
- adult (J80)
- newborn (P22,-)
- failure (J96,-)
- newborn (P28.5)

Perhatian Khusus : Respiratory arrest dapat ditegakkan sebagai diagnosis sekunder bila memenuhi seluruh kriteria

berikut ini :
(1). Terdapat usaha resusitasi dan atau pemakaian alat bantu nafas
(2). Bila terkait dengan diagnosis primer
(3).Merupakan perjalanan penyakit primer

139

Diagnosa	:	Pain locallized to upper abdomen (R10.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Deskripsi : Epigastric pain Kriteria eksklusi sub bab: gastrointestinal haemorrhage (K92.0-K92.2) · newborn (P54.0-P54.3) intestinal obstruction (K56.-) · newborn (P76.-) pylorospasm (K31.3) · congenital or infantile (Q40.0) Tanda dan gejala yang terjadi pada sistem urinari (R30-R39) gejala yang berhubungan dengan organ genitalia: · female (N94.-) · male (N48-N50) Eksklusi: dorsalgia (M54.-) flatulence and related conditions (R14) renal colic (N23)
Perhatian Khusus	:	-

140

Diagnosa : Other and unspecified abdominal pain (R10.4)

Prosedur : -

Aspek Koding : R10.4 Other and unspecified abdominal pain
Abdominal tenderness NOS
Colic:
· NOS
· infantile
R10-R19 Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
Kriteria ekslude
gastrointestinal haemorrhage (K92.0-K92.2)
gastrointestinal haemorrhage newborn (P54.0-P54.3)
intestinal obstruction (K56.-)
intestinal obstruction
newborn (P76.-)
pylorospasm (K31.3)
pylorospasm
congenital or infantile (Q40.0)
symptoms and signs involving the urinary system (R30-R39)
symptoms referable to genital organs:
female (N94.-)
male (N48-N50)

Perhatian Khusus : Cermati diagnosa banding dan kriteria penegakan diagnosa untuk gejala nyeri perut, misalnya: dispepsia, GERD, dan lain sebagainya.

141

Diagnosa	:	Fever (R50.9)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Termasuk didalamnya : Hyperpyrexia NOS Pyrexia NOS Kriteria eksklusi Sub bab: Fever of unknown origin (during)(in): labour (O75.2), newborn (P81.9) Puerperal pyrexia NOS (O86.4)
Perhatian Khusus	:	Konfirmasi penyebab demam yang spesifik sesuai klinis dan pemeriksaan penunjang, tata laksana dan pemeriksaan penunjang. Jika merupakan bagian tanda dan gejala dari suatu penyakit, maka tidak dapat dikoding terpisah.

142

Diagnosa	:	Febrile convulsions (R56.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	R56.0 Febrile convulsions Perhatikan pada kategori R56 Excludes : convulsions and seizures (in) : - dissociative (F44.5) - epilepsy (G40-G41) - newborn (P90)
Perhatian Khusus	:	Kode Kejang Demam (R56.0) digunakan sebagai diagnosis utama jika bukan gejala yang mewakili diagnosis sekunder dan memenuhi kriteria diagnosis utama.

143

Diagnosa	:	Trombositopeni, mual muntah, nyeri, dan kondisi gawat darurat lain yang didiagnosis dari pasien kanker pada kasus kegawatdaruratan
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Diagnosis yang dikoding dan dienty ke aplikasi INA-CBG adalah diagnosis kegawatdaruratan, sedangkan diagnosis kanker tidak dikoding dan dientri jika tidak ada tatalaksana untuk penyakit kanker.
Perhatian Khusus	:	-

144

Diagnosa	:	Diagnosis yang dilakukan di RS Khusus yang memerlukan tindakan seperti rehabilitasi medik, gigi, dan lainnya pada pasien kanker, dimana diagnosis tersebut bukan merupakan diagnosis kekhususan pada RS Khusus.
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Sesuai dengan Permenkes No.76 Tahun 2016 bahwa kode yang dinyatakan sebagai pelayanan sesuai kekhususannya adalah jika kode diagnosis utama sesuai dengan kekhususan rumah sakit. Daftar kode diagnosis untuk pelayanan yang sesuai dengan kekhususan rumah sakit, terdapat dalam lampiran permenkes No. 76 tahun 2016.
Perhatian Khusus	:	Perhatikan tatalaksana

XV. Cedera, Keracunan, dan Akibat Lain Tertentu Penyebab Eksternal

145

Diagnosa	:	Diagnosa utama: syok Hipovolemik dan dan diagnosa sekunder :Trauma Intrakranial dikoding T79.4 RS : Diagnosis R571 Diagnosis S067
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Sesuai instruksi excludes pada volume I sub bab shock, not elsewhere classified (R57) yang menyatakan shock (due to) traumatic mengarah pada kode traumatic shock (T79.4). Sehingga kode T79.4 digunakan untuk menggantikan shock hipovolemik yang ditemukan pada pasien dengan riwayat trauma. Diagnosa trauma intrakranial tetap dapat dikoding jika mendapatkan tata laksana.
Perhatian Khusus	:	Pastikan bahwa penyebab syock karena trauma

146

Diagnosa	:	Diagnosis Utama : Other intracranial injuries S06.8 Diagnosis Sekunder : Encephalopaty G93.4 Compression of brain G93.5 Respiratory failure, unspecified J96.9 Hemiplegia, unspecified G81.9 Prosedur : Other surgical occlusion of vessels,intracranial vessels 38.81

		Continuous invasive mechanical ventilation for 96 consecutive hours or more 96.72 Other craniotomy 01.24
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kode diagnosis utama seharusnya S06.2, kode G93.5 tidak dikoding jika karena traumatik karena sudah termasuk dalam kode S06.2, namun jika non-traumatik dan bisa dibuktikan (terutama dari disiplin ilmu lain) maka bisa dikoding
Perhatian Khusus	:	-

147

Diagnosa	:	Kombinasi Diagnosis S36.70 Injury of multiple intra-abdominal organs, without open wound Diagnosis R57.9 Shock, unspecified Kode revisi T79.4 Traumatic shock
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kondisi injury tetap dikoding sebagai diagnosa utama jika memang mendapat tata laksana utama. Kode T794 digunakan sebagai diagnosa sekunder karena merupakan komplikasi dari injury. Kode R579 tidak dikoding lagi, karena sudah ada kode T794 yang lebih spesifik.
Perhatian Khusus	:	Pastikan bahwa penyebab syock karena trauma

148

Diagnosa	:	Kombinasi Diagnosis T09.3 Injury of spinal cord, level unspecified Diagnosis R57.1 Hypovolaemic shock Kode revisi T79.4 Traumatic shock
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Kode hypovolaemic shock dapat diganti dengan kode T794, apabila kondisi shock hipovolemik disebabkan oleh trauma (sesuai kaidah ICD 10 Volume III). Namun kode injury tetap dikode jika mendapatkan tata laksana tersendiri.
Perhatian Khusus	:	Pastikan bahwa penyebab syock karena trauma

XVI. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan dan Kontak Dengan Pelayanan Kesehatan

149

Diagnosa	:	Follow-up care involving removal of fracture plate and other internal fixation device (Z47.0)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Z47.0 Follow-up care involving removal of fracture plate and ather internal fixation device Removal of : - pins - plates - rods - screws Pada sub kategori : Excludes : removal of external fixation device Z47.8 Pada sub Bab : Excludes : care involving rehabilitation procedures (Z50,-) complication of internal orthopaedic devices, implants and grafts (T84,-) follow-up examination ofter treatment of fracture (Z09.4)
Perhatian Khusus	:	Jika episode perawatan hanya untuk pengangkatan fiksasi internal, maka kode diagnosa fractur yang terkait tidak perlu digunakan.

150

Diagnosa	:	Kemoterapi Oral
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Tindakan kemoterapi oral menggunakan kode Z51.1 sebagai diagnosis utama dan kode neoplasma sebagai diagnosis sekunder
Perhatian Khusus	:	-

151

Diagnosa	:	Kemoterapi (Z51.1)
Prosedur	:	-
Aspek Koding	:	Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm Exclude : follow-up examination after treatment (Z08-Z09).
Perhatian Khusus	:	Perhatikan protokol kemoterapi, regimen dan billing. Jenis kanker/Ca dilihat dari hasil penunjang berupa hasil Patologi Anatomi penilaian keganasan sel atau analisis Bone marrow utk kasus keganasan pada sel darah. Untuk terapi adjuvan bukan merupakan bagian dari episode kemoterapi (tidak dapat menggunakan kode Z51).

TINDAKAN/PROSEDUR

I. Operasi pada Sistem Saraf

152

Diagnosa : Kode tindakan adhesiolisis Spinal Cord dan Nerve Root dengan teknik injeksi steroid dan analgetik
Pengajuan RS : 03.6
Verifikasi : 03.92

Prosedur : -

Aspek Koding : Koding dalam INA–CBG menggunakan ICD-10 revisi Tahun 2010 untuk mengkode diagnosis utama dan diagnosis sekunder serta menggunakan ICD-9-CM revisi Tahun 2010 untuk mengkode tindakan/prosedur

Lysis
adhesions
NOTE: blunt --omit code
digital --omit code
manual --omit code
mechanical --omit code
without instrumentation --omit code

Kata omit code (tidak dikoding)
Jika ada pernyataan omit code pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Permenkes 76/2016 Hal. 50)

Injection-
spinal (canal) NEC 03.92
alcohol 03.8

anesthetic agent for analgesia 03.91
for operative anesthesia --omit code
contrast material (for myelogram) 87.21
destructive agent NEC 03.8
neurolytic agent NEC 03.8
phenol 03.8
proteolytic enzyme (chymodiactin)
(chymopapain) 80.52
saline (hypothermic) 03.92
steroid NEC 03.92

Perhatian Khusus : Pada kasus ini, sesuai laporan operasi, DPJP melakukan tindakan adhesiolisis spinal root dengan teknik injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) Sesuai ICD9CM Tahun 2010, Adhesiolisis (Lysis Adhesion) dengan tindakan tumpul, menggunakan jari jemari, manual, mekanik, dan tanpa instrumen adalah omit code (tidak dikoding).
Tindakan adhesiolisis spinal root dengan teknik injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) adalah adhesiolisis tanpa instrumen (bedah) dan secara mekanik dengan menggunakan agen steroid sehingga tidak dikoding, namun yang dikoding adalah tindakan injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) tersebut. Sesuai ICD9CM, kode tindakan injeksi triamcinolon 80 mg (steroid) pada spinal root menggunakan kode 03.92.

II. Operasi pada Mata

153

Diagnosa	:	Glaucoma
Prosedur	:	Laser Iridotomy
Aspek Koding	:	Laser Iridotomy menggunakan Kode 12.12 (other Iridotomy)
Perhatian Khusus	:	-

154

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Tindakan YAG Laser pada kasus after cataract yang dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa cortex yang tertinggal.
Aspek Koding	:	Kode 13.64 (Discission of secondary membrane) [After Cataract] dapat digunakan pada Capsulotomy menggunakan YAG Laser. Kode 13.65 (Excision of Secondary membrane) [After Cataract] dapat digunakan pada Capsulectomy menggunakan YAG Laser.
Perhatian Khusus	:	Perhatikan indikasi medis tindakan sesuai panduan praktik klinis.

155

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	13.71 Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extract

Aspek Koding	:	13.71 Insertion of intraocular lens prostesis at time of cataract axtraction, one stage Code also synchronous extraction of cataract 13.11-13.69 Excludes : implantation of intraocular telescope prostesis 13.91
Perhatian Khusus	:	Pemasangan IOL pada ekstraksi katarak

III. Operasi pada Telinga

156

Diagnosa	:	OMSK Tympanic membrane (H72.0) Jaringan granulasi pada liang telinga (H60.3)
Prosedur	:	Ekstirpasi jaringan granulasi
Aspek Koding	:	- Jika prosedur eksisi pada telinga luar maka dikode 18.29 - Jika prosedur untuk biopsi jaringan telinga luar maka dikode 18.12 - Jika prosedur eksisi pada telinga luar dan biopsi maka dikode 18.29 (eksisi) dan 18.12 (biopsi)
Perhatian Khusus	:	-

IV. Operasi pada Sistem Pernapasan

157

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	WSD dan puncture of lung
Aspek Koding	:	Koding tindakan WSD adalah 34.04
Perhatian Khusus	:	-

V. Operasi pada Sistem Kardiovaskular

158

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Tindakan Av Shunt dengan tujuan renal dialysis
Aspek Koding	:	Jika tujuannya untuk dialisis maka koide yang digunakan adalah 39.27 (Arteriovenostomy for renal dialysis)
Perhatian Khusus	:	-

159

Diagnosa	:	Venous insufficienscy (CVI) (I87.2)
Prosedur	:	Endovaskular Radiofrequency Ablation pada vena
Aspek Koding	:	Kode tindakan adalah 39.79 (Other endovascular procedures on other vessels)
Perhatian Khusus	:	Dibuktikan USG Doppler

160

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	RFA (Radiofreqency Ablation)
Aspek Koding	:	RFA bisa dilakukan diberbagai organ, salah satunya di pembuluh darah vena. Indikasi dilakukan yaitu : - awal dilakukan terapi konservatif, - setelah 6 minggu gagal dilakukan, bisa dilakukan ligasi, skleroterapi atau RFA. Untuk RFA tidak boleh ada trombus vena, target vena safena, ukuran vena 2-20 mili. Fungsi

untuk obliterasi lumen/oklusi. Dari Radiologi tindakan dilakukan oleh Radiologi konsultan radiologi intervensi. Dilakukan dirawat inap karena merupakan tindakan yang dapat menimbulkan komplikasi. Jika dilakukan phlebectomy dilihat kembali apakah pada pembuluh darah yang sama atau berbeda.
Kode untuk RFA adalah 39.79

Perhatian Khusus : -

VI. Operasi pada Sistem Pecernaan

161

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	47.09 Other appendectomy
Aspek Koding	:	47.09 Other appendectomy Excludes : incidental appendectomy, so described laparoscopic 47.11 other 47.19
Perhatian Khusus	:	-

162

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Diagnosis utama Hirschsprung's disease ultra short segmen dan diagnosis sekunder Ileus obstruksi, Stenosis anus, dan Konstipasi
Aspek Koding	:	Prosedur yang dilakukan rectoscopy dan biopsi rectum (untuk kirim PA ke laboratorium)
Perhatian Khusus	:	Prosedur rectoscopy dilanjutkan dengan tindakan Biopsy maka dikode 48.24, sedangkan kode 48.35 merupakan kode untuk prosedur local excision of rectal lesion or tissue (tidak digunakan untuk biopsi).

163

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	49.46 excicion of haemorhoid
Aspek Koding	:	49.46 Excision of hemorrhoids Hemorrhoidectomy NOS)
Perhatian Khusus	:	Lihat laporan operasi terdapat eksisi pada benjolan di anus.

164

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	53.00 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified Inguinal herniorrhaphy NOS
Aspek Koding	:	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9CM Excludes: laparoscopic unilateral repair of inguinal hernia (17.11-17.13)
Perhatian Khusus	:	Cek kesesuaian laporan tindakan open approach atau endoscopic approach. Cek kesesuaian jenis hernia apakah betul hernia ingunalis.

165

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Tindakan laparatomi, adhesiolysis, Supravaginal histerektomi. Dikode dengan Excision or destruction of peritoneal tissue (54.4), Exploratory laparotomy (54.11), Other and unspecified vaginal hysterectomy (68.59)

Aspek Koding : ICD9CM 2010
Laparotomy NEC 54.19
as operative approach --omit code
Lysis
adhesions
NOTE: blunt --omit code
digital --omit code
manual --omit code
mechanical --omit code
without instrumentation --omit code
Kata omit code (tidak dikoding)
Jika ada pernyataan omit code pada Indeks Alfabet maka prosedur tersebut adalah bagian dari kode prosedur lain yang berhubungan dan tidak dikode (Permenkes 76/2016 Hal. 50)
Hysterectomy 68.9
abdominal 68.49
laparoscopic (total) [TLH] 68.41
partial or subtotal (supracervical) (supravaginal) 68.39

Perhatian Khusus : Kode yang diinput adalah tindakan histerektomi supravaginal : (68.39) sedangkan tindakan laparotomi (54.19) tidak dapat dikoding, Kode 54.4 (Excision or destruction of peritoneal tissue) dikoding terpisah dengan tindakan 68.39 dengan melakukan konfirmasi kepada DPJP mengenai tindakan yang dilakukan kepada pasien, terkait lokasi dan diagnosa, memastikan tindakan memang dilakukan.
Lakukan konfirmasi mengenai teknik adhesiolysis apakah menggunakan instrumen tajam (surgical)

karena pada ICD9CM teknik adhesiolysis yang omit code adalah teknik tumpul, digital, manual, mekanik atau tanpa instrumen
Lakukan konfirmasi organ spesifik yang terlibat adhesi karena penggunaan adhesiolysis terdapat beberapa alternatif sesuai dengan indeks alfabet lysis- Adhesion

166

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Kekeliruan entry kode diagnose dan prosedur atas kasus persalinan. Kesalahan input tindakan, yang seharusnya Re-hecting Post SC namun ditagihkan dengan tindakan SC
Aspek Koding	:	Pastikan kode yang di input dengan kesesuaian laporan tindakan. Untuk tindakan re hecting superfisial dan sederhana menggunakan kode 86.59. Jika deep dan kompleks menggunakan kode 54.61
Perhatian Khusus	:	Pastikan kembali tindakan yang dilakukan benar bukan persalinan SC melainkan re-hecting pasca operasi cesar saja.

167

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Insisi Peritoneum (54.95)
Aspek Koding	:	“54.95 Incision of peritoneum Exploration of ventriculoperitoneal shunt at peritoneal site

Ladd operation
Revision of distal catheter of ventricular shunt
Revision of ventriculoperitoneal shunt at peritoneal site

Perhatian Khusus : Perhatikan keterangan Excludes dalam ICD 9CM : That incidental to laparotomy (54.11-54.19)

VII. Operasi pada Sistem Saluran Kencing

161

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	RSWT (Radial Shock Wave Therapy)
Aspek Koding	:	- Jika tindakan yang dilakukan adalah untuk batu ginjal dengan menggunakan ultrasound maka kode yg digunakan adalah 59.95. - Jika menggunakan percutaneous nephrostomy dengan fragmentasi maka menggunakan kode 55.04. Jika pemecahan batu menggunakan Uerorenoscopy (URS) maka menggunakan kode 56.0 - Jika RSWT untuk kasus rehabilitasi medik maka kode yg digunakan adalah 00.09
Perhatian Khusus	:	-

162

Diagnosa : -

Prosedur : 59.8 Ureteral catheterization

Aspek Koding : 59.8 Ureteral catheterization
Drainage of kodney by catheter
Insertion of ureteral stent
Ureterovesical orifice dilation
Cade also any ureterotomy 56.2
Excludes : that for :
retrograde pyelogram 87.74
transurethral removal of calculus or clot from ureter and renal pelvis 56.0

Perhatian Khusus : Insersi stent ureteral, drainase ginjal dengan kateter

VIII. Operasi pada Organ Kelamin Laki-Laki

170

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	60.29 other trans uretral prostactomy
Aspek Koding	:	60.29 Transurethral prostatectomy Excision of median bar by transurethral approach Transurethral electrovaporization of prostrate (TEVAP) Transurethral anucleative procedure Transurethral prostatectomy NOS Transurethral resection of prostate (TURP)
Perhatian Khusus	:	Lihat laporan operasi dimana teknik operasi melalu uretra

171

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	69.02 Dilation and curettage following delivery or abortion
Aspek Koding	:	69.02 Other dilation and curettage Diagnostic D and C Exclude : aspiration curettage of uterus 69.51-69.59
Perhatian Khusus	:	69.01 jika untuk kuret terminasi kehamilan

IX. Operasi pada Organ Kelamin Perempuan

172

Diagnosa : -

Prosedur : Kistektomi pada ovari

Aspek Koding : Kode Kistektomi pada ovari menggunakan kode 65.2-

Perhatian Khusus : Pastikan tindakan yang dilakukan sesuai dengan laporan operasi

173

Diagnosa : -

Prosedur : 69.09 Other dilation and curettage (Diagnostic D and C)

Aspek Koding : Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9 CM
Excludes: aspiration curettage of uterus (69.51-69.59)

Perhatian Khusus : Cek kesesuaian laporan tindakan apakah betul kuret tajam atau kuret aspirasi. Tujuan kuret untuk keperluan diagnostik saja, bukan untuk kasus abortus.

174

Diagnosa	:	Kista Gardner (Q50.5) Anemia (D64.9)
Prosedur	:	Eksisi kista edhesiolisis
Aspek Koding	:	- Jika prosedur eksisi pada vagina (kista gartner) dikode 70.33 - Jika prosedur biopsi jaringan dikode 70.24 - Jika prosedur eksisi pada vagina dan biopsi maka dikode 70.33 dan 70.24
Perhatian Khusus	:	-

X. Prosedur/Tindakan Obstetrik

175

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	73.4 Medical induction of labor
Aspek Koding	:	73.4 Medical induction of labor Exclude : medication to auggment active labor --> omit code
Perhatian Khusus	:	-

176

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	73.59 Other manualy assited delivery
Aspek Koding	:	Bila terdapat penyulit/komplikasi maka penyulit/ komplikasi menjadi diagnosis utama. Metode persalinan sebagai Diagnosis Sekunder : O80.0-O80.9 outcome: Z37.0 - Z37.9 sebagai Diagnosis Sekunder
Perhatian Khusus	:	Kode ini digunakan pada partus spontan (tanpa bantuan alat)

177

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	73.6 Episiotomy Episioproctotomy Episiotomy with subsequent episiorrhaphy
Aspek Koding	:	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9CM Excludes: that with: high forceps (72.31) low forceps (72.1) mid forceps (72.21) outlet forceps (72.1) vacuum extraction (72.71)
Perhatian Khusus	:	Cek kesesuaian berkas apakah betul dilakukan episiotomy. Tindakan episiorrhaphy tidak dikoding terpisah apabila dilakukan setelah episiotomy pada episode yang sama

178

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	74.0 Classical cesarean section
Aspek Koding	:	74.0 Classical cesarean section Transperitoneal classical cesarean section Cade also any synchronous : hysterectomy 68.3-68.4, 68.6, 68.8) myomectomy 68.29 sterilization 66.31-66.39, 66.63
Perhatian Khusus	:	-

179

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	74.1, 74.4, 74.99 Caesar
Aspek Koding	:	Bila terdapat penyulit/komplikasi maka penyulit/ komplikasi menjadi diagnosis utama. Metode persalinan sebagai Diagnosis Sekunder : O80.0-O80.9 outcome: Z37.0 - Z37.9 sebagai Diagnosis Sekunder
Perhatian Khusus	:	-

180

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Repair Perineum (75.69)
Aspek Koding	:	Dalam ICD 9CM : 75.69 Repair Perineum Episioperineorrhaphy Repair of: pelvic floor perineum vagina vulva Secondary repair of episiotomy Excludes : repair of routine episiotomy (73.6) Repair pada rutin episiotomy saat persalinan normal dikoding dengan 73.6 (bukan kode 75.69)
Perhatian Khusus	:	-

XI. Operasi pada Sistem Muskuloskeletal

181

Diagnosa	:	Recurrent post op left proximal tibia suspect benign (Z03.1)
Prosedur	:	Wide excision
Aspek Koding	:	Kode 77.67 (Local excision of lesion or tissue of bone tibia and fibula) merupakan kode untuk prosedur pengangkatan lesi/tumor yang berasal dari jaringan tulang tibia dan fibula.
Perhatian Khusus	:	-

182

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Pemasangan gips/ removal gips dilakukan manipulasi sendi pada diagnosis fraktur atau dislokasi
Aspek Koding	:	Reduksi/manipulasi pada fraktur yang telah terpasang gips menggunakan kode 79.7.- dengan digit ke empat mengikuti lokasi anatomis
Perhatian Khusus	:	-

183

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Kode tindakan 83.39 pada tindakan pengambilan jaringan yang menurut DPJP adalah lymphadenopati tanpa ada hasil pemeriksaan patologi anatomi

Aspek Koding	:	ICD9CM 2010 Volume 3 Excision lesion - subcutaneous tissue 86.3
Perhatian Khusus	:	Sesuai ICD9CM 2010 Volume 3, tindakan pengambilan jaringan kulit dan subkutan menggunakan kode 86.3 dan tindakan eksisi/ pengambilan jaringan Kelenjar Getah Bening menggunakan 40.2 (tergantung lokasi anatomis Kelenjar Getah Bening) Jika ada pemeriksaan patologi anatomi, maka kode yang tepat adalah biopsy of skin dan subcutaneous tissue (86.11) atau biopsy of lymphatic structure (40.11) tergantung jenis jaringan yang diambil sebagai sampel (exclude dari kode eksisi (86.3 dan 40.2)

184

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Kode tindakan 83.39 pada tindakan pengambilan jaringan yang dalam yaitu mengenai kulit, subkutan, jaringan tumor, lapisan lemak dan jaringan dibawahnya tanpa ada hasil pemeriksaan patologi anatomi
Aspek Koding	:	ICD9CM 2010 Excision lesion - subcutaneous tissue 86.3 Pasien dengan tindakan eksisi STT dapat dirawat inap. a. Sesuai dengan indikasi medis pasien b. Narkose umum

Penggunaan kode berdasarkan lokasi STT:
a. Kode 83.39 untuk STT yang lokasinya dalam (otot, tendon)
b. kode 86.3 untuk STT yang superfisial (subkutis)

Perhatian Khusus : Sesuai ICD9CM 2010, tindakan pengambilan jaringan kulit dan subkutan menggunakan kode 86.3 dan jaringan lunak (soft tissue) menggunakan kode 83.3 (Tanpa adanya hasil pemeriksaan patologi anatomi)
Jika ada hasil pemeriksaan patologi anatomi, maka kode yang tepat adalah biopsi of skin and subcutaneous tissue (86.11) atau biopsy of soft tissue (83.21) tergantung dari jenis jaringan yang diambil sebagai sampel (exclude dari kode eksisi (86.3 dan 83.3)
Kedalaman lokasi STT, dapat dilihat dari :
- Laporan operasi atau
- Hasil biopsi
Penggunaan kode melihat dari lapisan kulit, apabila dilakukan eksisi luas tidak dalam menggunakan kode wide excision

185

Diagnosa : -

Prosedur : Kode tindakan 83.49 pada tindakan pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil : hibernoma pada bahu (deltoid)

Aspek Koding : ICD9CM 2010 Volume 3
Biopsy---
soft tissue NEC 83.21

Perhatian Khusus : Hibernoma adalah tumor jaringan lunak jinak yang terbentuk dari “”brown adipocytes””.
Sesuai ICD9CM Volume 3 ICD9CM 2010, kode untuk pemeriksaan patologi anatomi dengan hasil hibernoma adalah 83.21

XII. Operasi pada Sistem Integumentary

186

Diagnosa : -

Prosedur : 85.21 Local excision of lesion of breast

Aspek Koding : 85.21 Local excisionof quadrant of breast
Lumpectomy
Removal of area of fibrosis from breast
Excludes : biopsy of breast (85.11-85.12)

Perhatian Khusus : 85.2 Excision or destruction of breast tissue
Excludes : mastectomy (85.41-85.48)
reduction mammoplasty (85.31-85.32)

187

Diagnosa : -

Prosedur : 86.22 Excisional debridement of wound, infection, or burn

Aspek Koding : 86.22 dikoding jika pada laporan operasi terdapat eksisi dan debridemen pada luka atau karna luka bakar
Removal by excision of :
devitalized tissue
necrosis
slough
Excludes : debridement of :
abdominal wall (wound) 54.3
bone 77.60-77.69

muscle 83.45
of hand 82.36
nail (bed) (fold) 86.27
nonexcisional debridement of wound, infection, or burn 86.28
open francture site 79.60-79.69
pedicle or flap graft 86.75

Perhatian Khusus : Excludes: debridement of: abdominal wall (wound) (54.3) bone (77.60-77.69) muscle (83.45) of hand (82.36) nail (bed) (fold) (86.27) nonexcisional debridement of wound, infection, or burn (86.28) open fracture site (79.60-79.69) pedicle or flap graft (86.75)

188

Diagnosa : -

Prosedur : 86.28 Nonexcisional debridement of wound, infection, or burn

Aspek Koding : 86.28 Nonexcisional debridement of wound, infection, or burnd
Debridement NOS
Maggot therapy
Removal of devitalize tissue, necrosis and slough by such methods as :
brushing
irrigation (under pressure)
scrubbing
washing
Water scalpel (jet)

Perhatian Khusus	:	Tindakan pembersihan jaringan mati serta luka, untuk infeksi atau luka bakar Hati hati dengan kode tindakan insisi

189

Diagnosa	:	Lipoma regio punggung (D17.9)
Prosedur	:	Pto exsisi
Aspek Koding	:	Sesuai dengan diagnosis utama bahwa tindakan yang sesuai adalah 86.3 (Excision of lesion or tissue of skin and subcutaneous)
Perhatian Khusus	:	-

XIII. Prosedur/Tindakan Diagnostik dan Terapeutik Lainnya

190

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	DSA (Digital Subtraction Angiography)
Aspek Koding	:	DSA menggunakan kode prosedur 88.4- yang disesuaikan dengan organ yang dilakukan pemeriksaan.
Perhatian Khusus	:	Kode untuk DSA Carotid menggunakan kode 88.41

191

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Kode ICD 9 CM untuk tindakan TCD (Transkranial Doppler) dan CD (Carotid Doppler) tepatnya menggunakan kode 88.71
Aspek Koding	:	88.71 Diagnostic ultrasound of head and neck Determinaton of midline shift of brain Echoencephalography Exclude : eye 95.13
Perhatian Khusus	:	-

192

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Fibroscan
Aspek Koding	:	Fibroscan merupakan alat yang digunakan untuk

melihat fibrosis liver. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan non-invasif pengganti biopsi. Dokter yang dapat melakukan pemeriksaan ini adalah dokter sub spesialis penyakit dalam atau dokter Sp. PD yang telah mengikuti pelatihan.
Frekwensi untuk fibroscan tinggi, 50 Mhz, harus dengan probe khusus dan alat khusus. Untuk melihat severitas dari fibrosis. Kode tindakan untuk fibroscan adalah 88.76.

Perhatian Khusus : -

193

Diagnosa : -

Prosedur : USG pada Kehamilan

Aspek Koding : USG pada kehamilan dapat dikoding menggunakan kode 88.78. Namun jika USG uterus bukan untuk kehamilan maka menggunakan kode 88.79 (bila terbukti melakukan tindakan USG)

Perhatian Khusus : -

194

Diagnosa : -

Prosedur : Tindakan Papsmear

Aspek Koding : Jika tindakan yang dilakukan hanya pemeriksaan Papsmear maka hanya dikode 91.46

Perhatian Khusus : -

195

Diagnosa : -

Prosedur : Spinal traksi dilakukan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Aspek Koding : Spinal traksi yang dilakukan oleh Sp.KFR menggunakan kode 93.21 (manual and mechanical traction)

Perhatian Khusus : -

196

Diagnosa : -

Prosedur : 93.93 non mechanical method of resusitation

Aspek Koding : 93.93 Non mechanical method of resuscitation
Artificial respiration
Manual resusicitation
Mouth-tomouth resuscitation
Excludes :
insertion of airway 96.01 - 96.05
other continuous invasive (through endotracheal tube or
tracheostomy) mechanical ventilation 96.70 - 96.72

Perhatian Khusus : Lihat lembar observasi untuk tindakan resusitasi

197

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Slit Lamp (95.02)
Aspek Koding	:	Kode untuk tindakan Slit Lamp pada mata yang menggunakan kode 95.01 adalah untuk pemeriksaan mata terbatas, sedangkan kode 95.02 untuk pemeriksaan mata komprehensif
Perhatian Khusus	:	Pastikan jika ada resep kacamata, maka menggunakan kode 95.01

198

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Tindakan OCT (Optical Cohence tomography)
Aspek Koding	:	Kode tindakan OCT adalah menggunakan kode 95.16
Perhatian Khusus	:	-

199

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	96.07 Insertion of other (naso-) gastric tube Intubation for decompression
Aspek Koding	:	96.07 Insertion of other (naso-)gastritis tube Intubation for decompression Excludes: that for enteral infusion of nutritional substance (96.6)
Perhatian Khusus	:	Mohon diperhatikan sesuai kaidah koding ICD 9CM Cek apakah ada pemasangan NGT

200

Diagnosa : -

Prosedur : 96.71 continuous invansive mechanical ventilation for less then 96 hours

Aspek Koding : 96.71 Continuous invasive mechanical ventilation for less than 96 consecutive hours
Includes : Endotracheal respiratory assistance
BiPAP delevered through endotracheal tube or tracheostomy (invasive interface)
CPAP delivered through endotracheal tube or tracheostomy (invasive interface)
Invesive positive pressure ventilation (IPPV)
Mechanical ventilation through invasive interface That by tracheostomy
Weaning of an intubated (endotracheal tube) patient
Exclude : non-invasive continous positive airway pressure (BiPAP) 93.90
continuous negative pressure ventilation (CNP) (iron lung) (cuirass) 93.90
non-invasive continuous positive airway pressure (APAP) 93.90
intermitten poditive pressure breathing (IPPB) 93.91
non-invasive positive pressure (NIPPV) 93.90
that by face mask 93.90-93.99
that by nasal cannula 93.90-93.99
that by nasal catheter 93.90-93.99

Code also any associated :
endotracheal tube insertion 96.04
tracheostomy 31.1-31.29

Perhatian Khusus : Pastikan laporan tindakan intubasi yang terpasang ventilator mode mechanical

201

Diagnosa : -

Prosedur : 97.64 Removal of other urinary drainage device

Aspek Koding : 97.64 Removal of other urinary drainage device
Removal of indwelling urinary catheter

Perhatian Khusus : Lihat riwayat pemasangan diepisode sebelumnya, jika tidak ada riwayat pemasangan pada RS tsb lihat hasil BNO sebelum tindakan

202

Diagnosa : -

Prosedur : Tindakan angkat jahitan

Aspek Koding : Sesuai aturan ICD-9-CM Tahun 2010, tindakan / prosedur angkat jahitan dikode dengan memperhatikan lokasi tindakan/prosedur dilakukan.
Removal ---
suture(s) NEC 97.89 abdominal wall 97.83
by incision --see Incision, by site genital tract 97.79
head and neck 97.38 thorax 97.43
trunk NEC 97.84

Perhatian Khusus : -

203

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified
Aspek Koding	:	99.60 Cardiopulmonary resuscitation, NOS Excludes : open chest cardiac : electric stimulation 37.91 massage 37.91
Perhatian Khusus	:	Mohon diperhatikan cek resume medis apakah betul ada RJP? Kelengkapan billing? Perhatikan diagnosis sekunder cardiac arrest atau respiratory arrest?

204

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Kode tindakan fisioterapi di rehabilitasi medik yang tidak dirinci.
Aspek Koding	:	Tindakan/prosedur yang telah dilaksanakan ditulis dan dikode sesuai kaidah koding ICD-9-CM Tahun 2010 secara lengkap, jelas dan spesifik
Perhatian Khusus	:	-

205

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Kasus Rehabilitasi Medik (Rawat Jalan) Diatermi, tidak dikoding
Aspek Koding	:	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 tahun 2016 bahwa tindakan/prosedur yang

		telah dilaksanakan ditulis dan dikode sesuai kaidah koding ICD-9-CM Tahun 2010 secara lengkap, jelas dan spesifik
Perhatian Khusus	:	-

206

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Pembacaan ulang hasil biopsi dari sampel yang sudah ada, namun tidak dilakukan biopsi ulang.
Aspek Koding	:	Tindakan pemeriksaan biopsi tidak koding lagi.
Perhatian Khusus	:	-

207

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Aff hecting abdominal wall (97.83)
Aspek Koding	:	Untuk pengangkatan jahitan pada abdomen struktur otot, fascia, atau peritonium menggunakan kode 97.83 (Removal of abdominal wall sutures). Untuk pengangkatan jahitan pada kulit menggunakan kode 97.89 (Removal of other therapeutic device).
Perhatian Khusus	:	Pastikan diagnosis dan prosedur sesuai dengan yang dilakukan. Hasil grouper sesuai dengan aplikasi INA-CBG

208

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Lepas dan pasang kateter
Aspek Koding	:	Kode untuk tindakan Lepas kateter adalah menggunakan kode 97.64, sedangkan tindakan pasang kateter menggunakan kode 57.94
Perhatian Khusus	:	Pastikan prosedur sesuai dengan yang dilakukan. Hasil grouper sesuai dengan aplikasi INA-CBG



Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG

Edisi 2

ADMINISTRASI

1

Diagnosa : Pada kasus Haemofilia, harus ada rujukan balik (protokol terapi) dari PPK 3 dan surat rujukan menyusul, tidak bisa diklaimkan sebagai kasus Haemofilia.

Prosedur : -

Perihal Administrasi: -

Solusi Administrasi : Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02.02/MENKES/523/2015 bahwa Peresepan Produk Darah Faktor VIIa (rekombinan), hanya boleh diberikan oleh hematolog dewasa atau hematolog anak.
Yang diterima adalah kasus dengan protokol terapi yang sudah ada namun tidak dibawa. Untuk yang belum ada protokol terapi dan tidak ada penegakan diagnosis dari PPK 3 sebelumnya, tidak diberikan penjaminan

Perhatian Khusus : -

2

Diagnosa : Penggunaan kode Z09.8 pada RS Khusus Kanker dan ditagihkan dengan tarif RS Khusus, koding ini digunakan pada kasus follow up HIV

Prosedur : -

Perihal Administrasi: -

Solusi Administrasi : Pasien kontrol diluar diagnosa kekhususan (diluar fokus treatment) pada RS khusus diklaimkan satu tingkat kelas tarif dibawahnya.

Kode Z09.8 pada diagnosa kekhususan : di klaimkan sesuai dengan kelas RS khusus
Kode Z09.8 pada diagnosa non kekhususan : diklaimkan satu tingkat kelas tarif dibawahnya

Perhatian Khusus : -

3

Diagnosa : -

Prosedur : -

Perihal Administrasi: Apakah operasi eviserasi dan enukleasi dengan anestesi umum disarankan dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A ?

Solusi Administrasi : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 yaitu :
Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat darurat,
kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas
Kriteria rujukan sesuai dengan indikasi medis, kompetensi dokter, dan sarana prasarana yang tersedia. Selama mempunyai fasilitas dan memilki kompetensi yang sesuai, tidak perlu di rujuk.

Perhatian Khusus : -

4

Diagnosa : -

Prosedur : -

Perihal Administrasi: Pada prosedur kombinasi seperti SICS/ Fakoemulsifikasi_IOL+trabekulektomi atau ECCE+IOL+eksisi pterygium+graft, perhitungan klaim dihitung satu atau dua prosedur ?

Solusi Administrasi : Tindakan/prosedur yang telah dilaksanakan ditulis dan dikode sesuai kaidah koding ICD-9-CM Tahun 2010 secara lengkap, jelas dan spesifik.

Perhatian Khusus : -

5

Diagnosa : -

Prosedur : -

Perihal Administrasi: Pada pemeriksaan rawat jalan beberapa prosedur pemeriksaan seperti pemeriksaan refraksi dan koreksi kacamata dengan autorekfraktometer, pemeriksaan slit lamp, pemeriksaan funduskopi direk/indirek, pemeriksaan tekanan intrakular dengan tonometer, apakah mempuyai jasa pemeriksaan/klaim tersendiri

Solusi Administrasi : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 bahwa untuk FKRTL BPJS Kesehatan akan membayar dengan sistem paket INA CBG's dan di luar paket INA CBGs.

		Pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem INA CBGs terhadap FKRTL berdasarkan pada pengajuan klaim dari FKRTL baik untuk pelayanan rawat jalan maupun untuk pelayanan rawat inap.
Perhatian Khusus	:	-

6

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	-
Perihal Administrasi	:	Apabila setiap koding yang tadinya sudah di acc dan telah dibayar tapi ternyata pada kasus yang sama dibulan yang berbeda verifikasinya berubah kodingnya. Apakah RS harus selalu mengembalikan kelebihan bayar tersebut, yang tadinya sudah di acc. mengapa tidak dibebankan kepada kedua belah pihak?
Solusi Administrasi	:	Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, terdapat hak dan kewajiban para pihak dimana masing-masing pihak berkewajiban membayar / mengembalikan kekurangan/kelebihan pembayaran dalam hal terjadinya kekurangan / kelebihan pembayaran atas dugaan incorrect claim (ketidaksesuaian klaim) atau terindikasi kecurangan berdasarkan hasil audit.
Perhatian Khusus	:	-

7

Diagnosa : -

Prosedur : -

Perihal Administrasi: Obat Alteplase, Anistreolase, Reteplase, Tenecteplase TPA, dan Urokinase apakah bisa di Top up

Solusi Administrasi : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 Tahun 2016 bahwa salah satu pembayaran tambahan (Top Up) dalam sistem INA-CBG adalah special drugs pemberian Streptokinase. Pemberian obat Alteplase, Anistreolase, Reteplase, Tenecteplase TPA dan Urokinase tidak bisa diberikan pembayaran tambahan (Top Up INA-CBG).

Perhatian Khusus : -

8

Diagnosa : -

Prosedur : -

Perihal Administrasi: Kelas rawat Peserta yang dirawat inap di ruangan IGD atau ruang non kelas seperti ruang observasi/ peralihan/ ruangan kemoterapi

Solusi Administrasi : Kelas klaim dibayarkan setara dengan kelas 3

Perhatian Khusus : -

9

Diagnosa : -

Prosedur : Pet Scan

Perihal Administrasi: Pemberian Pelayanan Pet Scan

Solusi Administrasi : Kriteria tindakan Pet Scan yaitu :

a) Penjaminan layanan Pet Scan dilakukan apabila pemeriksaan penunjang radiologi diagnostik dengan CT Scan atau MRI tidak memberikan hasil yang jelas.
b) Pemberian rekomendasi Pet Scan diberikan oleh Cancer Board atau tim dokter multidisiplin yang merawat.
c) Penggunaaan Pet Scan diindiikasikan untuk unknown primary tumor atau difficult case. Untuk diagnosis lain diperlukan rekomendasi dari dokter spesialis onkologi.

Prosedur pelayanan dan pengajuan klaim Pet Scan yaitu :

a) Rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan Pet Scan adalah rumah sakit minimal kelas B.
b) Pasien melampirkan hasil CT Scan atau MRI sebelumnya.
c) Pet Scan dilakukan satu kali selama perjalanan penyakit.
d) Pengajuan klaim Pet Scan pada kasus rawat jalan adalah tarif non INA-CBG (tarif INA-CBG rawat jalan tidak diajukan)
e) Pengajuan klaim Pet Scan pada rawat inap dilakukan diluar aplikasi INA-CBG

Perhatian Khusus : -

10

Diagnosa : -

Prosedur : Rehabilitasi Psikososial

Perihal Administrasi: Pelayanan Rehabilitasi Psikososial

Solusi Administrasi : Pemberian layanan rehabilitasi psikosoial dapat diberikan pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap.

a) Layanan rehabilitasi Psikososial pasien rawat inap meliputi :
   - Psikofarmaka (Manajemen Pengobatan)
   - Psikoedukasi (Psychoeducation)
   - Manajemen Kasus (Case Management)
   - Latihan Keterampilan Sosial (Social Skill Training)
   - Latihan Keterampilan Hidup (Life Skill Training)
   - Terapi Vokasi (Vocational Therapy)
   - Terapi Occupational (Ocupational Therapy)
   - Dukungan Hidup (life Support)
   - Spiritual - Contoh Best Practice
   - Rehabilitasi Kognitif (Cognitive Rehabilitation)
   - Komunitas Terapeutik (Therapeutic Community)

b) Layanan Rehabilitasi Psikososial rawat jalan meliputi :
   - Psikoedukasi (Psychoeducation)
   - Manajemen Kasus (Case Management)
   - Latihan Keterampilan Sosial (Social Skill

Training)
- Latihan Keterampilan Hidup (Life Skill Training)
- Terapi Vokasi (Vocational Therapy)
- Terapi Occupational (Ocupational Therapy)
- Dukungan Hidup (life Support)
- Spiritual - Contoh Best Practice
- Rehabilitasi Kognitif (Cognitive Rehabilitation)
- Komunitas Terapeutik (Therapeutic Community)

c) Kriteria penjaminan pelayanan rehabilitasi psikososial rawat jalan diberikan kepada pasien berdasarkan seleksi sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan kriteria :
- Gangguan jiwa berat (Skizofrenia, Depresi, Bipolar, Skizoafektif)
- Pasien tidak gelisah (PANSS EC <15)
- Pasien bukan retardasi mental sedang dan berat (IQ>55)
- Tes fungsi kognitifnya masih cukup baik (MMSE>20)
- Keluarga pasien kooperatif- Gejala negatif minimal
- Pasien dapat berkomunikasi
- Pasien dapat membaca dan menulis, minimal pendidikan SD
- Pasien berusia mulai dari 19 th – 50 th

d) Kriteria penjaminan pelayanan rehabilitasi psikososial rawat inap ditentukan oleh dokter spesial jiwa yang menjadi DPJP pasien tersebut.

Perhatian Khusus : a) Untuk pelayanan rawat jalan diklaimkan setiap kali kunjungan mengacu pada tarif INA CBG sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang berlaku.

b) Untuk pelayanan rawat inap diklaimkan setiap episode mengacu pada tarif INA CBG sesuai dengan peraturan menteri kesehatan yang berlaku.

Jenis pelayanan rehabilitasi psikososial dan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan rehabilitasi psikososial terlampir.



Panduan Manual Verifikasi Klaim INA-CBG

Edisi 2

MEDIS

1

Diagnosa	:	Diagnosis sekunder Shock Kardiogenik pada kasus meninggal
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	"Kondisi Syok Kardiogenik dapat menjadi diagnosis sekunder terutama pada pasien penyakit jantung dengan bukti tertulisnya kriteria klinis dalam rekam medis berupa : 1. Penurunan Tekanan Darah a. TD < 90 mmHg tanpa inotropik, atau b. TD < 80 mmHg dengan inotropik 2. Penurunan Ejection Fraction (EF < 50%)
Perhatian Khusus	:	Tidak boleh dikoding bila tidak tegak secara medis dan tidak ada resource khusus

2

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	USG pada Kehamilan (88.76/88.79)
Aspek Medis	:	Dalam kondisi kehamilan normal, prosedur USG dilakukan sebanyak 3 kali (1 kali tiap trimester). Pada kehamilan dengan indikasi medis lainnya membutuhkan lebih banyak prosedur USG.
Perhatian Khusus	:	-

3

Diagnosa	:	Pneumonia/ Bronkopneumonia
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Pneumonia dapat didiagnosis sesuai dengan KMK RI No. HK. 02.02/MENKES/514/2015 yaitu jika pada foto toraks terdapat infiltrat baru atau infiltrat progresif ditambah dengan 2 atau lebih gejala dibawah ini : 1. Batuk-batuk bertambah 2. Perubahan karakteristik dahak / purulen 3. Suhu tubuh > 38°C (aksila) / riwayat demam 4. Pemeriksaan fisik : ditemukan tanda-tanda konsolidasi, suara napas bronkial dan ronki 5. Leukosit > 10.000 atau < 4500
Perhatian Khusus	:	-

4

Diagnosa	:	TB Paru (A15)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	TB Paru dapat didiagnosis dengan melampirkan hasil pemeriksaan penunjang positif (imaging, BTA) dan mendapatkan tatalaksana khusus berupa Obat Anti Tuberkulosis dan edukasi untuk minum obat. Jika hasil BTA negatif maka menggunakan kode A16.-
Perhatian Khusus	:	-

5

Diagnosa	:	Hiponatremi
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kondisi dimana kadar natrium lebih rendah dari nilai normal (Na < 135 mEq/L), maka kondisi tersebut tetap dikatakan sebagai hiponatremia, dan dapat digunakan sebagai diagnosa sekunder apabila ada tatalaksana/terapi diberikan. Pada anak natrium dibawah 130 dan/atau terdapat kondisi klinis kejang atau penurunan kesadaran atau dehidrasi berat. Untuk dengan penyerta penyakit jantung dibawah 135.
Perhatian Khusus	:	-

6

Diagnosa	:	Hipokalemia
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kondisi dimana kadar kalium lebih rendah dari nilai normal (K < 3,5 mEq/L), maka kondisi tersebut tetap dikatakan sebagai hipokalemia, dan dapat digunakan sebagai diagnosa sekunder apabila ada tatalaksana/terapi diberikan. Hipokalemi pada anak kalium dibawah 3 dan/atau ada gejala klinis kelemahan otot atau kembung atau aritmia atau bising usus menurun. Pada pasien dengan penyakit penyerta jantung maka kalium dibawah 3,5.
Perhatian Khusus	:	-

7

Diagnosa : Hipertensi disertai dengan Renal Failure.
Sesuai dengan ICD 10 tahun 2010 volume 1 yang termasuk pada kode I12 (hypertensive renal disease) adalah semua kondisi pada kode N00–N07, N18.-, N19 atau N26 karena hipertensi.
Untuk kasus Gagal Ginjal Akut atau Acute Renal Failure (N17) tidak termasuk pada kode I12 (hypertensive renal disease)

Prosedur : -

Aspek Medis : Hipertensi disertai dengan Renal Failure.
Sesuai dengan ICD 10 tahun 2010 volume 1 yang termasuk pada kode I12 (hypertensive renal disease) adalah semua kondisi pada kode N00–N07, N18.-, N19 atau N26 karena hipertensi.
Untuk kasus Gagal Ginjal Akut atau Acute Renal Failure (N17) tidak termasuk pada kode I12 (hypertensive renal disease)

Tahap	Kreatinin serum	Output urine
I	Peningkatan kreatinin serum 0,3 mg/dl dalam 48 jam atau ≥ 1,5 - 1,9 kali dari baseline	< 0,5 ml/kg BB/jam dalam 6 jam
II	Peningkatan kreatinin serum ≥ 2 - 2,9 kali dari baseline	< 0,5 ml/kg BB/jam dalam > 12 jam

III	Peningkatan kreatinin serum ≥ 3 kali dari baseline atau > 4 mg/dl dengan peningkatan akut minimal 0,5 mg/dl atau membutuhkan terapi pengganti ginjal	< 0,3 ml/kg BB/jam dalam > 24 jam atau anuria selama 12 jam

Perhatian Khusus : -

8

Diagnosa : Hipovolemik Syok

Prosedur : -

Aspek Medis : Hipovolemik shock dapat digunakan sebagai diagnosis sekunder apabila terdapat manifestasi klinis yang sesuai dan adanya tatalaksana. Adapun tatalaksana minimal untuk kondisi hipovolemik shock adalah dengan adanya loading cairan. Pengecualian kasus, hypovolemic shock sebagai diagnosis sekunder tetap dapat digunakan tanpa tatalaksana spesifik pada kondisi pasien gawat yang sudah meninggal terlebih dahulu sebelum mulai diberikan tatalaksana.

Perhatian Khusus : -

9

Diagnosa : -

Prosedur : Colonoscopy (45.23)

Aspek Medis : Pada pasien-pasien geriatri dengan risiko dehidrasi, maka diperbolehkan untuk dilakukan rawat inap. Pada pasien usia muda atau geriatrik

dengan kecemasan yang tinggi, serta pasien dengan perdarahan masif sehingga diperlukan perbaikan keadaan umumnya.

Perhatian Khusus : -

10

Diagnosa : Beta thalassaemia (D56.1)

Prosedur : Transfusion of packed cells (99.04)

Aspek Medis : Tindakan transfusi darah seharusnya dapat dilakukan dengan episode rawat jalan. Nilai Hb ataupun jumlah kantung darah yang akan diberikan, tidak dijadikan dasar dilakukannya transfusi dengan episode rawat inap.
Transfusi pada anak :
Transfusi darah merupakan transplantasi organ sehingga dapat dilakukan di rawat inap karena pemberian transfusi membutuhkan waktu minimal 4 jam dan setelah transfusi harus dimonitoring dalam waktu 4 jam.
Indikasi transfusi pada anak di rawat inap yaitu HB < 6 dan/atau sesak.
Jika ada komplikasi Decompesation Cordis dan reaksi transfusi.
Pemberian transfusi maksimal 4 kali dalam sebulan dengan kriteria salah satunya sebagai berikut :
1. Transfusi HB < 10
2. Hipersplenisme

Perhatian Khusus : -

11

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Skingraft
Aspek Medis	:	Skin graft tidak dapat dijamin pada kasus yang berhubungan dengan estetik. Layanan estetik adalah layanan medis yang dilakukan pada bagian tubuh yang normal untuk memperbaiki penampilan atau aroma (tidak mengganggu fungsi). Contoh : Hipo/hiperpigmentasi pasca inflamasi, deposit lemak, tato.
Perhatian Khusus	:	Perhatikan penggunaan koding graft, pastikan tindakan graft wajar dilakukan pada pasien (misalnya pada luka/injury yang luas dan dalam), jika hanya luka kecil dikoding skin graft (86.69) perlu dikonfirmasi.

12

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Educational Therapy (93.82)
Aspek Medis	:	1. Episode sesuai dengan aturan episode rawat jalan. Kode untuk konsultasi gizi adalah 89.07 (Consultation, described as comprehensive) 2. Pelayanan klinik gizi adalah yang dilakukan oleh dokter spesialis gizi klinik
Perhatian Khusus	:	Perhatikan penggunaan koding graft, pastikan tindakan graft wajar dilakukan pada pasien (misalnya pada luka/injury yang luas dan dalam),

jika hanya luka kecil dikoding skin graft (86.69) perlu dikonfirmasi.

13

Diagnosa : Anemia

Prosedur : -

Aspek Medis : Anemia pada persalinan:

1. Standar Diagnosis Anemia dapat menggunakan standar WHO
2. Jika terdapat bukti klinis (lab), anemia tetap dikoding

Anemia sebagai diagnosis sekunder adalah anemia yang disebabkan oleh :

1. Komplikasi penyakit utamanya (dimana terapi anemia berbeda dengan terapi utamanya), contoh : pasien kanker payudara yg diradioterapi, pada perjalanannnya timbul anemia maka anemia tersebut dapat dimasukkan diagnosa sekunder dan stadium lanjut, dll) yang memerlukan transfusi darah dan eritropoetin harus dimasukkan
2. Anemia gravis (Hb < 8) pada penyakit kronik (contoh : gagal ginjal kronik, kanker, dll) ke dalam diagnosis sekunder karena memerlukan pengobatan khusus yg berbeda dari penyakit dasarnya.

Perhatian Khusus : -

14

Diagnosa : Leukositosis (D72.8)

Prosedur : -

Aspek Medis :
1. Leukositosis (D72.8) yang dimasukkan sebagai diagnosis sekunder bukanlah leukositosis yang disebabkan karena infeksi atau karena pemberian obat-obatan (GCSF, Steroid) dan myeloproliferatif neoplasma (MPN)
2. Leukositosis pada kehamilan bukan merupakan diagnosis penyakit tersendiri, oleh karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosis utamanya.
   Pada Kehamilan jumlah leukosit sd 16.000 / mikro liter masih fisiologis.

Perhatian Khusus : -

15

Diagnosa : Leukopenia-Agranulositosis (D70)

Prosedur : -

Aspek Medis :
1. Dalam penegakan diagnosis perlu mencantumkan bukti medis (hasil lab)
2. Diagnosis leukopenia (D70) pada pasien kanker adalah leukosit dibawah 3000 dan harus dituliskan diluar diagnosa kankernya karena hal ini berdampak pada pemberian GCSF pasca kemoterapi sampai leukosit diatas atau sama dengan 4000.

Perhatian Khusus : -

16

Diagnosa : Efusi Pleura (J90-J91)

Prosedur : -

Aspek Medis : Efusi pleura sebagai diagnosis sekunder apabila memenuhi salah satu Kriteria berikut ini:

1. Efusi pleura dengan jumlah berapapun dan penyebabnya apapun yang terbukti terdapat cairan dengan tindakan pungsi pleura/ thorakosintesis
2. Efusi pleura yang terbukti dengan pemeriksaan imaging (foto toraks dan/ atau USG toraks dan/ atau CT Scan toraks) dengan jumlah minimal atau lebih dari minimal yang disertai dengan tindakan punksi pleura (tidak harus keluar cairan) dan / atau tatalaksana tambahan sesuai penyebabnya diluar tatalaksana diagnosis primer.

Definisi efusi pleura dengan jumlah minimal bila memenuhi salah satu kriteria berikut :

1. Gambaran efusi pada foto toraks lateral decubitus dan/ atau CT Scan toraks dengan ketebalan kurang dari 10 mm.
2. Gambaran efusi pada USG toraks dengan jumlah cairan kurang dari 100 ml dan/atau jarak antara pleura parietal dan pleura viseral kurang dari 10 mm.

Perhatian Khusus : -

17

Diagnosa : Respiratory Failure (Gagal Nafas)

Prosedur : -

Aspek Medis : Kriteria gagal napas akut (acute respiratory failure) (J96.0) apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

1. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan pO2 < 60 mmHg dan / atau SaO2 < 91%
2. Hasil pemeriksaan pulse oksimetri menunjukkan SpO2 < 91%
3. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan pO2 / FIO2 (P/F) ratio < 300
4. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan pCO2 > 50 mmHg dengan pH < 7,35
5. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan peningkatan pCO2 ≥ 10 mmHg dari nilai dasar (bila diketahui hasil analisis gas darah sebelumnya)

Kriteria gagal napas kronik (chronic respiratory failure) (J96.1) apabila memenuhi kriteria berikut ini:

Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan seluruh kriteria berikut:

a. peningkatan pCO2 > 50 mmHg
b. peningkatan bikarbonat (HCO3) > 24 mmHg
c. pH normal (7,35 – 7,45)
d. pO2 < 60 mmHg dan / atau SaO2 < 91%

Kriteria gagal napas akut pada gagal napas kronik (acute on chronic respiratory failure) adalah pasien dengan riwayat gagal napas kronik apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

1. Perburukan gejala klinis berupa penurunan kesadaran atau sesak napas atau gasping
2. Hasil pemeriksaan analisis gas darah atau pulse oksimetri menunjukkan:
   a. Hasil pemeriksaan gas darah yang menunjukkan penurunan pO2 <60 mmHg dan/ atau penurunan SaO2 <91%
   b. Hasil pemeriksaan pulse oksimetri menunjukkan penurunan SpO2 <91%
3. Hasil pemeriksaan analisis gas darah menunjukkan peningkatan pCO2 > 50 mmHg dan pH < 7,35

Tatalaksana salah satu dibawah ini :

1. Terapi oksigen dengan :
   - Low flow: nasal kanul, masker simple, rebreathing mask, non-rebreathing mask
   - High flow: venturi mask, high flow nasal kanul
2. Ventilasi non invasif: CPAP, BiPAP
3. Ventilasi invasive (ventilator)

Perhatian Khusus : -

18

Diagnosa	:	Respiratory Arrest (R09.2)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Definisi respiratory arrest adalah berhentinya proses bernapas yang dibuktikan dengan tidak adanya frekuensi napas. Tatalaksana salah satu dibawah ini : 1. Ventilasi buatan: mouth to mouth ventilation, bag mask ventilation dengan atau tanpa oropharyngeal airway. 2. Ventilasi mekanik invasive
Perhatian Khusus	:	-

19

Diagnosa	:	Disfagia (R13)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Diagnosis sekunder Disfagia (R13) dapat dikoding bersama dengan Prosedur Tonsilektomi (28.2) pada kondisi sebagai berikut : 1. Pasien Anak 2. Terdapat gizi kurang akibat gangguan menelan dimana berat badan kurang dibanding usia atau IMT menurut usia
Perhatian Khusus	:	-

20

Diagnosa : Hemiparese/ Hemiplegia

Prosedur : -

Aspek Medis : Tidak semua kasus stroke disertai dengan Hemiplegia/Hemiparese. Untuk pasien dengan Hemiplegia di rawat inap ada tindakan fisioterapi.

Perhatian Khusus : -

21

Diagnosa : Vertigo

Prosedur : -

Aspek Medis : Indikasi vertigo dapat dirawatinap :

1. Vertigo (R42) sentral dengan etiologinya : Stroke (iskemik, hemoragik), infeksi akut dan kronik, trauma kepala, tumor intraserebral dengan peningkatan tekanan intra kranial.
2. Vertigo perifer (H81.3) dengan kriteria muntah hebat yaitu jika pasien kesulitan
   a. tanda - tanda dehidrasi
   b. gangguan hemodinamik (salah satu dari takikardi, nadi lemah, hipotensi)
   c. gangguan elektrolit
   d. hipoglikemi

Perhatian Khusus : -

22

Diagnosa : Katarak

Prosedur : -

Aspek Medis : ECCE dirawat inap karena insisi lebih besar dan kemungkinan komplikasi besar. Jika ada underlying disease seperti HT, DM, HBSAg + atau indikasi medis lain yang mendapatkan tata laksana khusus dan asuhan spesialis lain selama perawatan.
Usia pediatrik < 18 th.

Perhatian Khusus : -

23

Diagnosa : Pterigium (H11.0)

Prosedur : -

Aspek Medis : Rawat Inap:

1. Pterigium (H11.0) Grade IV
2. Operasi dengan teknik Graft Conjungtiva, Flap conjungtiva, atau membran amnion baik dengan jahitan atau membran glue
3. Pasien anak-anak atau pasien yang tidak kooperatif yang memerlukan anestesi umum
4. Ada keperluan sistemik yang memerlukan evaluasi baik dibidang mata maupun dari departemen lain
5. Terdapat perdarahan masif atau komplikasi lain yang memerlukan evaluasi lebih lanjut

Rawat jalan:
Operasi Pterigium (H11.0) tanpa penyulit (Kondisi seperti yang diindikasikan pada Rawat Inap) dan

dikerjakan dengan Bare Sklera

Perhatian Khusus : -

24

Diagnosa : Chalazion (H001)

Prosedur : -

Aspek Medis : Tindakan ini dilakukan di Rawat jalan kecuali pada anak-anak yang belum kooperatif/ memerlukan Anestesi Umum (GA)

Perhatian Khusus : -

25

Diagnosa : Extrapiramidal Syndrom

Prosedur : -

Aspek Medis : 1. Skala penilaian Gejala Ekstrapiramidal syndrom (G25.9) yang ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia digunakan sebagai panduan diagnosis Ekstrapiramidal Syndrom untuk dokter dan dapat dipergunakan sebagai verifikasi bersama verifikator.
2. Skala penilaian gejala Ekstrapiramidal syndrom yang ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dipergunakan sebagai verifikasi bersama verifikator jika terjadi keraguan diagnosis.

Perhatian Khusus : -

26

Diagnosa	:	Epistaxis
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kondisi perdarahan yang terjadi pada kasus DHF harus dinyatakan sebagai diagnosis sekunder karena hal tersebut penting dalam menentukan penatalaksanaan selanjutnya, dan bukti pendukungnya adalah adanya penatalaksanaan perdarahan dalam rekam medis.
Perhatian Khusus	:	-

27

Diagnosa	:	Volume Depletion (E86)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Gastoenteritis dapat dirawatinap atas dasar volume depletion/dehidrasi, dan bukti pendukungnya adalah adanya penatalaksanaan terapi cairan.
Perhatian Khusus	:	-

28

Diagnosa	:	Gagal Ginjal dengan HD
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Pasien renal failure dengan HD dapat dirawat inap sesuai indikasi medis yang spesifik (contoh. Anemia), bukan atas perbaikan keadaan umum (KU).
Perhatian Khusus	:	-

29

Diagnosa : -

Prosedur : Endoskopi (45.11)

Aspek Medis : Pasien dengan tindakan endoskopi dapat dirawat inap berdasarkan keadaan umum pasien.

Perhatian Khusus : -

30

Diagnosa : -

Prosedur : Colonoscopy (45.23)

Aspek Medis : Pasien dengan tindakan kolonoskopi dapat dirawat inap berdasarkan keadaan umum pasien.

Perhatian Khusus : -

31

Diagnosa : Asfiksia

Prosedur : -

Aspek Medis : KRITERIA DIAGNOSIS ASFIKSIA NEONATORUM (UKK Neonatologi - IDAI) :

1. ASFIKSIA BERAT
   a. Apnea atau megap megap yang membaik setelah resusitasi minimal dengan 3 siklus ventilasi tekanan positif, ATAU
   b. Pemeriksaan analisis gas darah dari arteri umbilikal menunjukkan asidosis metabolik atau mixed yang berat dengan pH< 7 atau base deficit ≥ 12 mmol/L, ATAU
   c. Ada manifestasi gangguan neurologis (misal: kejang, koma, tonus otot jelek), ATAU

d. Ada keterlibatan multi organ (misal: ginjal, jantung, paru, hati, usus), ATAU
e. FJ <100 X/menit saat lahir dan cenderung menurun atau tetap, ATAU
f. skor Apgar 0-3 sampai 1 menit ATAU <5 sampai 5 menit setelah lahir

2. ASFIKSIA RINGAN/SEDANG
a. Bayi bernapas spontan setelah resusitasi maksimal dengan 2 siklus ventilasi tekanan positif, ATAU
b. Pemeriksaan analisis gas darah dari arteri umbilikal menunjukkan asidosis metabolik atau mixed dengan pH 7,0 sampai kurang dari 7,35, ATAU
c. Skor Apgar 5-6 sampai 5 menit setelah lahir

Perhatian Khusus : -

32

Diagnosa : Syok saat Operasi (T811)

Prosedur : -

Aspek Medis : Syok saat operasi menjadi sebagai diagnosis sekunder jika memang dalam rekam medis tertulis manifestasi klinis syok yang merupakan komplikasi operasi serta tertulis penatalaksaan syok tersebut.

Perhatian Khusus : -

33

Diagnosa : -

Prosedur : Scleroterapy pada Hemorhoid (49.42)

Aspek Medis : Pasien dengan tindakan Scleroterapi pada hemorhoid dapat dirawat inap berdasarkan keadaan umum pasien.
Indikasi Rawat Inap Hemorhoid memenuhi kriteria salah satu diantara berikut ini :
1. Hemorhoid interna grade IV
2. Hemorhoid yang memerlukan tindakan intervensi
3. Kombinasi hemorhoid interna dan hemorhoid eksterna dengan simptomatis menonjol (perdarahan HB < 10 atau anemia atau nyeri skala>5)
4. Hemorhoid mengalami fibrosis (striktur)
5. Hemorhoid disertai kelainan lain fistula / fisura.

Indikasi hemorhoidectomy :
1. Grade III dan IV
2. Grade II dengan dengan salah satu dari perdarahan akut, perdarahan kronis dengan anemia, trombosis.

Indikasi skleroterapi pada Hemorhoid yaitu Hemorhoid interna grade I atau II disertai atau tanpa disertai perdarahan tidak ada batasan berapa kali.

Perhatian Khusus : -

34

Diagnosa	:	Hypertensive renal disease with renal failure (I12.0) dengan Pulmonary oedema (J81)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kriteria Pulmonary Oedema: gejala klinis sesak, takikardi, ronki Ada penatalaksanaan pulmonary oedema yang terekam dalam resume medis dan ada terapi diuretik dan oksigen yang diberikan. Pada kasus HD rutin yang dirawat inap dengan kondisi pulmonary oedema, maka Diagnosis Sekunder Pulmonary Odema dan Diagnosis utama CKD (bukan kontrol HD atau kode Z).
Perhatian Khusus	:	-

35

Diagnosa	:	Hypertensive renal disease with renal failure (I12.0) dengan Ascites (R18)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kriteria Rawat Inap untuk Ascites adalah Ascites masif, tujuan tindakan Pungsi untuk Terapeutik. Bila terjadi pada kasus CKD, maka diagnosis ascites dapat menjadi diagnosis sekunder dan diagnosis utamanya adalah CKD
Perhatian Khusus	:	-

36

Diagnosa : Insufisiensi renal (N19)

Prosedur : -

Aspek Medis : Kriteria penegakan diagnosa Insufisiensi renal:
Nilai GFR kurang dari 60 atau nilai creatinin wanita diatas 1,1 dan pria diatas 1,3.
Pada anak dilakukan pemeriksaan urieum kreatinin berulang.

Perhatian Khusus : -

37

Diagnosa : Urinary Tract Infection, site not specified (N39.0)

Prosedur : -

Aspek Medis : Diagnosa ISK dibuat berdasarkan salah satu dari kriteria dibawah ini :

1. Gejala klinis yang khas (minimal satu): sakit kencing, nyeri perut bagian bawah, nyeri tekan suprapubic, anyang-anyangan, nyeri pinggang, nyeri ketok costovertebral angle (CVA) dengan atau tanpa disertai demam dan jumlah lekosit urin lebih dari 10/LPB
2. Kultur urin positif

Perhatian Khusus : -

38

Diagnosa	:	Ventricular fibrillation and flutter (I49.3)
Prosedur	:	EKG (8952)
Aspek Medis	:	Ventricular Fibrillation harus disertai dengan diagnosis jantung yang potensial menyebabkan henti jantung dan dilakukan tata laksana sesuai dengan tatalaksana henti Jantung.
Perhatian Khusus	:	-

39

Diagnosa	:	Non spesific reactive hepatitis (K75.2)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kriteria diagnosis hepatitis reaktif non spesifik bila SGOT/SGPT diatas nilai normal dan mendapatkan tata laksana khusus.
Perhatian Khusus	:	-

40

Diagnosa	:	Gout arthritis (M10.9)
Prosedur	:	Other local excision or destruction of lession of ankle joint (80.87)
Aspek Medis	:	Kriteria rawat inap untuk pasien Gout Arthritis adalah Gout dengan banyak sendi 3 atau lebih atau Gout Polyarticular atau Gout yang dirawat karena penyakit lain atau gout dengan nyeri hebat VAS >=7
Perhatian Khusus	:	Kode Tindakan untuk injeksi artikular adalah 81.92 (injection of therapeutic substances into joint or ligaments)

41

Diagnosa : Osteoarthritis

Prosedur : Injeksi Intraartikular

Aspek Medis : Injeksi intraartikular pada kasus osteoarthritis dilakukan di rawat jalan.

Perhatian Khusus : -

42

Diagnosa : Phlebitis

Prosedur : -

Aspek Medis : Phlebitis dapat digunakan sebagai diagnosis sekunder bila dilakukan penatalaksanaan khusus, seperti diantaranya debridement atau pemberian antibiotik.

Perhatian Khusus : -

43

Diagnosa : Septikemia

Prosedur : -

Aspek Medis : Penegakan diagnosis sepsis dapat mengikuti kriteria SIRS (systemic inflamatory response syndrome) yaitu terdiri dari minimal 2 keadaan:

1. Temperatur >38,5 derajat celcius atau <36 derajat celcius
2. Denyut Jantung >90 x/menit
3. Frekuensi pernafasan >20x/menit atau PaCO2 <32 mmHg (Pada pemeriksaan AGDA)
4. Terdapat respons tubuh terhadap fokal infeksi, peradangan, dan stres dengan hasil

laboratorium menunjukkan leukositosis dan wajib melampirkan bukti kultur darah dengan hasil bakterimia.

Apabila diagnosis sepsis dapat ditegakkan maka harus diikuti dengan tata laksana sepsis.

Perhatian Khusus : -

44

Diagnosa : Alergi Obat

Prosedur : -

Aspek Medis : Alergi obat (T88.7) adalah reaksi lokal atau sistemik akibat pemberian obat oral atau parenteral, atau topikal, inhalasi atau metode pemberian obat lainnya untuk mengobati suatu penyakit, tidak termasuk alergi karena hasil skin test.

Alergi obat yang menjadi sebab perawatan saat itu atau yang terjadi pada saat perawatan berlangsung dapat dijadikan diagnosis sekunder. Informasi tersebut dicantumkan pada resume medis pasien saat pulang rawat.

Perhatian Khusus : -

45

Diagnosa : CKD

Prosedur : -

Aspek Medis : CKD dengan komplikasi penyakit lain dapat dirawat inap lebih dari satu kali sesuai dengan indikasi medis.

Indikasi medis rawat inap CKD pada anak memenuhi salah satu kriteria berikut :

1. overload dengan tanda - tanda sesak atau bengkak di kelopak mata/kaki/perut.
2. Imbalance elektrolit (Hiponatremi/hipokalemi/hipokalsemi/hiperkalemi/hiperkalsemi)
3. Pemasangan akses dialisis
4. Malfungsi akses dialisis
5. Hipoalbumin kurang dari 2,5
6. Memerlukan transfusi sesuai kriteria

Perhatian Khusus : -

46

Diagnosa : Atrial Fibrilasi (I48 & I64)

Prosedur : -

Aspek Medis : Kriteria diagnosis

1. Anamnesis
2. EKG :
   - Laju ventrikel bersifat ireguler
   - tidak terdapat gelombang P yang jelas
   - Gel P digantikan oleh gelombang F yang ireguler dan acak, diikuti oleh kompleks QRS yang ireguler pula.
   - secara umum: Laju jantung umumnya berkisar 110-140x/menit, tetapi jarang melebihi 160-170x/menit.
   - Dapat ditemukan denyut dengan konduksi aberan (QRS lebar) setelah siklus interval RR panjang-pendek (fenomena Ashman) • Preeksitasi • Hipertrofi ventrikel kiri • Blok berkas cabang • Tanda infark akut/lama

3. Foto torax :
   Pemeriksaan foto toraks biasanya normal, tetapi kadangkadang dapat ditemukan bukti gagal jantung atau tanda-tanda patologi parenkim atau vaskular paru (misalnya emboli paru, pneumonia).

Perhatian Khusus : -

47

Diagnosa : -

Prosedur : Kateterisasi jantung/Cor angiografi

Aspek Medis : Indikasi tindakan cor angoigrafi mengacu pada Panduan Praktik Klinis (PPK) dan Clinical Pathway (CP) Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah PERKI yaitu mengacu kepada setiap diagnosis.
Khusus untuk diagnosis angina pektoris, hanya dilakukan untuk pasien dengan CCS 3-4 (simptomatik) atau riwayat infark miokard lama. Sedangkan angina pektoris dengan CCS 1- 2, dilakukan pemeriksaan ischemic stress test meliputi Treadmill test, atau Echocardiografi Stress test, atau Stress test perfusion scanning atau MRI.
CCS adalah klasifikasi derajat angina sesuai Canadian Cardiovascular Society (CCS)
CCS Kelas 1: Keluhan angina terjadi saat aktifitas berat yang lama
CCS Kelas 2: Keluhan angina terjadi saat aktifitas yang lebih berat dari aktifitas sehari-hari
CCS Kelas 3: Keluhan angina terjadi saat aktifitas sehari-hari
CCS Kelas 4: Keluhan angina terjadi saat istirahat

Perhatian Khusus : -

48

Diagnosa : -

Prosedur : kateterisasi jantung standby PCI

Aspek Medis : Standby PCI adalah tindakan Coronary Angiografi (CAG) yang dilanjutkan dengan PCI apabila ditemukan lesi signifikan (pada episode yang sama). Rekomendasi PERKI dilakukan untuk pasien STEMI, NSTEMI, Angina Pectoris (AP) CCS 3-4.

Perhatian Khusus : -

49

Diagnosa : -

Prosedur : Tahapan Pemasangan stent (PCI)

Aspek Medis : Sesuai dengan PPK Perki hal 6, 7 dan 8 Angina Pectoris, hal 9-11, 13,14 dan 15 hanya mengatur indikasi PCI ulang bagi kasus-kasus multivessel disease dimana CABG mempunyai risiko tinggi (Fraksi ejeksi rendah, usia >75 tahun atau pembuluh distal kurang baik untuk grafting). PCI lanjutan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 1-3 bulan kemudian jika kondisi klinis stabil.

Perhatian Khusus : -

50

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	PCI
Aspek Medis	:	Indikasi tindakan PCI yaitu Intervensi koroner perkutan (PCI) atau CABG elektif dilakukan jika ditemukan bukti iskemik dari pemeriksaan penunjang (ischemic stress test) disertai lesi signifikan berdasarkan pemeriksaan angiografi koroner. Kriteria lesi signifikan : LM stenosis 50%, LAD stenosis di osteal/proksimal >50%, LAD stenosis di mid-distal > 70%, LCx stenosis > 70%, dan RCA stenosis >70%. Pada lesi-lesi non signifikan yang dijumpai bukti adanya iskemia yang luas memerlukan pemeriksaan menggunakan FFR (flow fraction ration). Nilai FFR < 0,8 menunjukkan lesi signifikan. Pada tempat yang tidak memiliki fasilitas FFR maka pemeriksaan iskemik stress test dapat membantu apakah lesi sebagai penyebab iskemik.
Perhatian Khusus	:	-

51

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	CABG
Aspek Medis	:	Indikasi CABG : Lesi multiple stenosis (> 2 pembuluh koroner) dengan atau tanpa diabetes mellitus. Pada kasus-kasus multivessel disease dimana

CABG mempunyai risiko tinggi (Fraksi ejeksi rendah, usia >75 tahun atau pembuluh distal kurang baik untuk grafting) maka dapat dilakukan PCI selektif dan bertahap (selective and Stagging PCI) dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien, lama radiasi, jumlah zat kontras dan lama tindakan.
PCI lanjutan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 1-3 bulan kemudian jika kondisi klinis stabil. PCI lanjutan harus dipercepat jika terdapat keluhan bermakna (simptomatik).

Perhatian Khusus : -

52

Diagnosa : -

Prosedur : Primary PCI pada keadaan emergency

Aspek Medis : Harus staging tidak bisa dilakukan sekaligus karena memiliki dampak komplikasi yang lebih rendah. Namun, indikasi PCI lanjutan dapat dikerjakan dalam kurun waktu 1-3 bulan kemudian jika kondisi klinis stabil atau PCI lanjutan harus dipercepat jika terdapat keluhan bermakna (simptomatik).

Perhatian Khusus : -

53

Diagnosa : -

Prosedur : Cor angiografi/kateterisasi jantung

Aspek Medis : Indikasi CAG ulang bagi pasien mengacu kepada diagnosis terakhir. Sehingga apabila keadaan pasien terakhir memiliki diagnosis angina pektoris,

		maka hanya dilakukan untuk pasien dengan CCS 3-4 (simptomatik) atau riwayat infark miokard lama.
Perhatian Khusus	:	-
54		
Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Pemasangan stent yang berulang
Aspek Medis	:	Tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa pemasangan stent berulang hanya dapat dilakukan di PPK 3.
Perhatian Khusus	:	-
55		
Diagnosa	:	Left Main dan Three Vessel Disease (CAD)
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Sepanjang ada pelayanan bedah jantung dengan kompetensi. Left main dan Three Vessel Coronary Disease merupakan indikasi dilakukan CABG. Jika antrian lebih dari 6 bulan untuk CABG maka bisa dilakukan selektif PCI jika memungkinkan. Tidak ada regulasi yang mengatur FKRTL mana yang boleh melakukan CABG, sepanjang ada pelayanan bedah jantung dengan kompetensi yang sesuai.
Perhatian Khusus	:	-

56

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Pemeriksaan MSCT
Aspek Medis	:	Pemeriksaan imaging MSCT / sidik perfusi jantung bagi Asimptomatik Risiko Tinggi Penyakit Jantung Koroner hanya dilakukan jika exercise test tidak memungkinan. Pasien dengan resiko tinggi penyakit jantung koroner (PJK) menurut skor risiko Framingham atau terdapat salah satu faktor resiko mayor PJK antara lain: diabetes, hipertensi, dislipidemia, menopause, perokok, pria usia >40 tahun, dan faktor keturunan PJK.
Perhatian Khusus	:	-

57

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Pemeriksaan perfusi miokard
Aspek Medis	:	Untuk mengetahui adanya iskemik atau mengetahui viabilitas otot jantung pada pasien pasien yang akan dilakukan revaskularisasi. Contoh pada pasien yang tidak dapat dilakukan treadmill test atau hasil treadmill tes sugestif positif iskemik respon atau inconclusive/unadequate/border line.
Perhatian Khusus	:	-

58

Diagnosa : NSTEMI

Prosedur : Cor Angiografi/Kateterisasi jantung

Aspek Medis : Stratifikasi risiko di IGD untuk menentukan strategi invasif.

a. Pasien risiko sangat tinggi sebaiknya dikerjakan PCI dalam 2 jam dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan fasilitas cathlab. Kriteria risiko sangat tinggi bila terdapat salah satu kriteria berikut:
   - Angina berulang
   - Syok kardiogenik
   - Aritmia malignant (VT, VF,TAVB)
   - Hemodinamik tidak stabil
   - Pasien dengan peningkatan enzim jantung namun tanpa kriteria risiko sangat tinggi diatas, dirawat selama 5 hari dan dapat dilakukan standby PCI.

Perhatian Khusus : -

59

Diagnosa : -

Prosedur : RIRS (Retrograde Intra Renal Surgery)

Aspek Medis : RIRS merupakan metode operasi yang baru. Indikasi untuk batu ginjal. Kekurangan dari ESWL tidak bisa prediktif batu nya habis atau tidak. Pada ESWL prosentase remuknya batu. RIRS hampir sama dengan URS tapi RIRS sampai ke ginjal. Angka bebas batunya akan lebih bagus. Guidelines

baru akan dibuat IAUI. Berdasarkan prioritas, Sarana yang tersedia (bisa menginduced). Dari sisi cost ESWL lebih murah, tapi bisa berkali kali. RIRS dilakukan di OK dengan sedasi general atau regional. Dilakukan di rawat inap. Kompetensi dokter spesialis urologi di semua tipe RS. RIRS diantara PCNL dan ESWL. ukuran batu kurang dari 2 cm dan lokasi batu menentukan prosedur yang akan dilakukan. Batu kurang dari 2cm anjuran dengan ESWL sama dengan RIRS, kecuali batu pada calyx inferior. Jika lebih dari 2cm dengan PCNL atau open surgery.

Perhatian Khusus : Kode tindakan RIRS adalah 56.0.

60

Diagnosa : Kejang

Prosedur : -

Aspek Medis : R56 Convulsions, not elsewhere classified
Excludes: convulsions and seizures (in):
· dissociative (F44.5)
· epilepsy (G40-G41)
· newborn (P90)
R56.0 Febrile convulsions
R56.8 Other and unspecified convulsions
Fit NOS
Seizure (convulsive) NOS

Perhatian Khusus : Kejang dari jenisnya bisa dibagi kejang umum dan kejang parsial. Kejang umum granmal,pasien tidak sadar. Kejang parsial, pasien sadar. Secondary generalized. Ketika terjadi kejang,

obatnya diazepam. Berdasarkan penyebab Kejang simptomatik ada yang idiopatik. contoh kejang simptomatik Kejang pada tumor otak, kejang pada pasien stroke, kejang pada infeksi. Kejang idiopatik contohnya epilepsi. Untuk pasien epilepsi kejang berulang minimal dua kali dengan pola yang sama dan dibuktikan dengan hasil EEG yang abnormal. Pada penegakan kasus epilepsi harus dengan EEG.

61

Diagnosa	:	Kejang Deman pada anak
Prosedur	:	-
Aspek Medis	:	Kejang demam dapat menjadi diagnosis utama bila: 1. tidak ada diagnosis lain yang menjadi penyebab kejang dan/atau 2. diperlukan obat anti kejang intravena
Perhatian Khusus	:	Kejang dari jenisnya bisa dibagi kejang umum dan kejang parsial. Kejang umum granmal,pasien tidak sadar. Kejang parsial, pasien sadar. Secondary generalized. Ketika terjadi kejang, obatnya diazepam. Berdasarkan penyebab Kejang simptomatik ada yang idiopatik. contoh kejang simptomatik Kejang pada tumor otak, kejang pada pasien stroke, kejang pada infeksi. Kejang idiopatik contohnya epilepsi. Untuk pasien epilepsi kejang berulang minimal dua kali dengan pola yang sama dan dibuktikan dengan hasil EEG yang abnormal. Pada penegakan kasus epilepsi harus dengan EEG.

62

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Eksploratory Laparatomy
Aspek Medis	:	Pada diagnosis appendicitis dan hernia dilakukan ekploratory laparotomy. Appendicitis disertai dengan perforasi dan menimbulkan peritonitis harus dilakukan laparotomy ekplorasi. Hernia yang disertai dengan perforasi dan menimbulkan peritonitis harus dilakukan laparotomy explorasi.
Perhatian Khusus	:	-

63

Diagnosa	:	-
Prosedur	:	Eksploratory Laparotomy Incidental
Aspek Medis	:	Prosedur eksploratory laparotomi incidental yang dilakukan bukan merupakan prosedur utama dan tidak direncanakan.
Perhatian Khusus	:	-